

regulación bioeléctrica

EL CUERPO ELÉCTRICO

Manual de Regulación Bioeléctrica

*El fundamento, los siete ejes de trabajo y la
conducción de la serie de sesiones.*



Dr. Miguel Ojeda Rios
Instituto Centrobioenergetica

MANUAL DEL MÉTODO
EDICIÓN 2026



CONTENIDO

Índice

PARTE I · EL FUNDAMENTO COMÚN A TODOS LOS EJES

BLOQUE I · EL FUNDAMENTO

11 1 Definición del método

12 2 Antecedentes

14 3 El voltaje de membrana

16 4 La matriz extracelular

17 5 Clases de agente

20 6 El sistema que se regula

BLOQUE II · EL INSTRUMENTO

26 7 Cómo llega el campo a la célula

27 8 Intensidad y alcance

29 9 El gradiente

30 10 Dispositivos de profundidad

BLOQUE III · VOCABULARIO Y LECTURA

32 11 Nodo y dipolo

33 12 El indicador

34 13 La medición

36 14 La isla bioeléctrica



BLOQUE IV · EL PROCEDIMIENTO

38 15 La regla del rastreo

40 16 Lectura del nivel

41 17 La rejilla

42 18 Tiempo y retiro

BLOQUE V · SEGURIDAD Y DERIVACIÓN

45 19 Situaciones que obligan a valorar

45 20 Hallazgos que obligan a derivar

46 21 Urgencias

BLOQUE VI · REGISTRO Y MÉTODO DE TRABAJO

47 22 La ficha y el mapa de sensaciones

48 23 Disciplina del rastreo

BLOQUE VII · LOS LÍMITES DE LA TÉCNICA

50 24 Niveles del dolor

51 25 Sobre qué opera la técnica

53 26 La regla del imán

PARTE II · LOS EJES



BLOQUE VIII · LOS EJES DE ENTRADA

58 **27** La acidosis**61** **28** El nodo de lesión**63** **29** Los tipos de dolor

BLOQUE IX · EL EJE TRANSVERSAL

64 **30** El programa de defensa**65** **31** El tono de defensa**66** **32** El ciclo defensivo completo**67** **33** Los nodos del eje del estrés**71** **34** Los 10 nodos bilaterales**73** **35** La ventana de tolerancia**74** **36** La conducción de la sesión**75** **37** Qué separa esta técnica de una terapia emocional

BLOQUE X · EL EJE DIGESTIVO

77 **38** El epitelio y el voltaje**78** **39** Las 11 unidades funcionales**80** **40** Las células intersticiales de Cajal**81** **41** El orden interno del eje**81** **42** La entrada al eje**82** **43** La reprogramación vagal bioeléctrica



83 44 Qué se pregunta y qué se anota

84 45 Qué obliga a derivar en este eje

BLOQUE XI · EL EJE METABÓLICO

85 46 Los cinco lugares de falla

87 47 Los nueve nodos de inflexibilidad metabólica

89 48 El páncreas endocrino

90 49 El hígado

92 50 El tejido adiposo

93 51 La grasa que no se rastrea

BLOQUE XII · LOS EJES INFLAMATORIO Y REDOX

94 52 El nodo de órgano o tejido inflamado

95 53 Las ventanas de descanso

96 54 La placa arterial

97 55 El eje redox

PARTE III · CONDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO

BLOQUE XIII · LA SESIÓN Y LA SERIE

102 56 Con qué eje se empieza

103 57 Cuando el rastreo no da hallazgos

104 58 La serie de sesiones

105 59 Hasta dónde llega el método

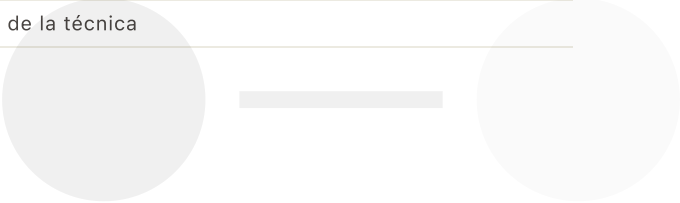


PARTE I

El fundamento común a todos los ejes

Qué evalúa el método, con qué instrumento, con qué vocabulario se lee, con qué regla se rastrea y dentro de qué límite se aplica.

BLOQUE I	El fundamento
BLOQUE II	El instrumento
BLOQUE III	Vocabulario y lectura
BLOQUE IV	El procedimiento
BLOQUE V	Seguridad y derivación
BLOQUE VI	Registro y método de trabajo
BLOQUE VII	Los límites de la técnica





El razonamiento del método

Un tejido conserva el estado en el que debe funcionar bajo la forma de un voltaje de membrana. Ese voltaje determina qué canales iónicos se abren, y del flujo de iones que resulta salen el pH, la resistividad y el estado de oxidación-reducción, que son las tres variables con las que se describe cualquier medio. El mismo voltaje decide si una célula prolifera o se diferencia, qué secreta una glándula y qué deja pasar una unión estrecha. Es, en ese sentido, la variable que organiza: las demás se desplazan detrás de ella.

Si el estado de referencia de un tejido está escrito en su voltaje, la enfermedad crónica admite una lectura distinta de la habitual. No corresponde necesariamente a un tejido dañado, sino a un tejido que sostiene una referencia que dejó de corresponder a la situación presente. El caso que lo muestra con más claridad es la inflamación crónica: el macrófago mantiene su fenotipo inflamatorio porque no ha recibido la información de que el proceso terminó, y esa información llega por vía eléctrica.

De ahí que la intervención consista en modificar el voltaje. Un imán no hace nada más que eso. No aporta cargas, no aporta energía y no transfiere sustancia alguna: genera un gradiente de campo, ese gradiente deforma la geometría de la membrana, y con ello se modifica el estado de los canales. Los cuatro mecanismos descritos convergen en el mismo punto.

Y si el efecto depende de la geometría de la membrana y no de la fuerza con que se muevan los iones, se sigue una consecuencia que gobierna toda la práctica: aumentar la intensidad del imán no aumenta el resultado. Lo que lo determina es el gradiente y el sitio donde se coloca.

El sitio, sin embargo, no se deduce del nombre de la enfermedad. Dos personas con el mismo diagnóstico presentan mapas bioeléctricos distintos, y el mapa cambia además de una sesión a otra. Si el sitio no se deduce, hay que encontrarlo, y encontrarlo exige un procedimiento de lectura que devuelva una respuesta del tejido y no una impresión del operador.

Esa lectura llega por el iliopsoas. El cambio de voltaje que introduce el imán se propaga por las uniones comunicantes, modifica el tono de ese músculo y se observa como acortamiento de una extremidad. La extremidad no contiene información sobre la zona interrogada: lo que se lee es la respuesta del sistema completo a la perturbación. Por eso la medición tiene que repetirse igual en cada colocación, y por eso la respuesta no depende de la sensibilidad de quien explora.

Encontrado el nodo, el nivel en el que la colocación restablece la isometría informa de la escala a la que pertenece el disturbio. Un hallazgo que nivela en local corresponde a un proceso acotado al lugar; uno que solo nivela al incorporar el riñón, la suprarrenal, el hígado o el bulbo compromete a un órgano regulador más.

Todo lo anterior delimita el alcance del método. Lo que es estructura no responde, porque no tiene punto de ajuste que reescribir. Lo que se organiza en un nivel del dolor distinto del tisular no responde, porque esta técnica trabaja el primero. Y lo que corresponde a las metas o al horizonte de anticipación del sistema queda fuera, porque la técnica edita restricciones y reabre operadores, y nada más.

Los 26 capítulos que siguen desarrollan esa cadena. Todos los ejes de la Parte II se apoyan en ellos, y ninguno los repite.



BLOQUE I

El fundamento

Qué evalúa el método, de dónde procede, cuál es la variable que organiza el tejido, en qué medio ocurre, por qué un campo magnético puede modificarla y de qué partes se compone un sistema que se regula.

1

Definición del método

Tiene dos momentos: el rastreo del estado bioeléctrico y la aplicación que lo modifica.

RASTREO Y APLICACIÓN

La Regulación Bioeléctrica evalúa el estado bioeléctrico de un tejido y regula su microambiente mediante campos magnéticos estáticos de intensidad moderada.

El trabajo tiene dos momentos:

MOMENTO	QUÉ PRODUCE
---------	-------------

Rastreo	El mapa del estado bioeléctrico de la persona en esa sesión
---------	---

Aplicación	La colocación de imanes que modifica el voltaje de membrana de la zona hallada
------------	--

Se ejecuta bajo un perfil y un sistema definidos. Sin sistema, la exploración carece de criterio para decidir dónde colocar el imán y qué significa la respuesta.

El estado que el rastreo lee es dinámico y tiene estructura sistematizada. Cambia de una sesión a otra, y al mismo tiempo responde a reglas fijas. De esa segunda propiedad depende que la lectura sea reproducible entre operadores, condición que el capítulo 26 recoge una vez descritos el indicador y el procedimiento de medición que la sostienen.

QUÉ DEVUELVE EL RASTREO

- 01 La densidad de los disturbios bioeléctricos: uno, dos o varios.
- 02 La vecindad entre ellos: si aparecen en un solo lugar o repartidos en tres o cinco órganos.
- 03 Cómo se manifiestan en la salud de la persona.

Dos personas con el mismo diagnóstico dan perfiles bioeléctricos distintos. El mapa corresponde a esa persona y a esa sesión, y no se deduce del nombre de una enfermedad. De esta propiedad depende que el método necesite un procedimiento de búsqueda, y no una tabla de correspondencias.

QUÉ NO MIDE

El método evalúa el estado del microambiente del tejido, que corresponde al primer nivel de organización de la biología. No mide emociones, ni microorganismos, ni contenidos mentales.

Con el rastreo se identifica el estado bioeléctrico de una zona: el hígado, el ojo, la piel, y estructuras de menor tamaño como la esclera o el iris. Se emplea el término microambiente tisular.

LA DENOMINACIÓN DE CADA NODO ES ANATÓMICA

El nodo se nombra por la zona del cuerpo donde se coloca el imán. Un nodo llamado rodilla-rodilla recibe ese nombre porque ahí se localiza un desequilibrio bioeléctrico, y no porque corresponda a un contenido emocional.

ALCANCE Y LÍMITE PROFESIONAL

La evaluación integra datos de laboratorio, síntomas clínicos y manifestaciones conductuales, y se realiza sin necesidad de formación médica.

El método no sustituye ningún tratamiento médico. El diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad corresponden al médico.

2

Antecedentes

El patrón de voltaje decide si el tejido regenera o cicatriza.

La afirmación del capítulo anterior –que existe un estado bioeléctrico del tejido y que puede leerse– no procede del método. Procede de dos líneas de trabajo previas, una experimental y otra clínica: el método conserva de cada una cosas diferentes.

EL VOLTAJE DEL MUÑÓN DECIDE SI LA EXTREMIDAD REGENERA O CICATRIZA

Becker midió el potencial eléctrico en el muñón de anfibios amputados y encontró que el patrón de voltaje determina si el tejido regenera o cicatriza.



MOMENTO	VOLTAJE	RESULTADO
Extremidad íntegra	-10 mV	Estado basal
Inmediatamente después de la amputación	+20 mV	Despolarización
Salamandra, en los días siguientes	-30 mV	Se forma el blastema y nace la extremidad completa
Rana, en los días siguientes	-10 mV	Cicatriz sin regenerar

El blastema es la masa de células no diferenciadas que se organiza en el muñón y de la que se reconstruye la extremidad.

De ese trabajo salen cuatro hallazgos que el método utiliza:

- 01 El organismo tiene un mapa eléctrico propio, con polaridades definidas: el centro positivo y las extremidades negativas.
- 02 El voltaje instruye la regeneración. Sin el patrón de voltaje adecuado no ocurre ni la regeneración ni la cicatrización.
- 03 La polaridad influye sobre el desarrollo bacteriano. Con plata y voltaje positivo, más un campo de polo negativo, se frenó el desarrollo de bacterias en cultivo. Es el único dato disponible sobre el efecto de un campo eléctrico o magnético sobre microorganismos, y el efecto es indirecto: el campo modifica el voltaje de la zona, y a partir de ahí cambia el comportamiento del biofilm.
- 04 El hueso es piezoeléctrico. Genera corriente al recibir carga mecánica, y se deforma al aplicarle corriente.

EL ACORTAMIENTO DE LA EXTREMIDAD, COMO SIGNO MEDIBLE

La segunda línea es clínica. Broeringmeyer describió que, al colocar un imán en el centro del pecho, una de las extremidades inferiores se acorta respecto de la otra, y registró un primer catálogo de 150 zonas del cuerpo con esa respuesta.

Su procedimiento partía de una barra magnética colocada sobre la línea media del tórax. Al aplicar polos sobre el hígado y el riñón, y medir el pH de la orina, encontró que la cifra se desplazaba. De esa observación salió la primera relación entre imanes y pH, y el catálogo de zonas que la técnica sigue usando.

Ese signo es el que se mide en todo el método. El mecanismo por el que se produce no estaba descrito entonces y se expone en el capítulo 12.

QUÉ SE CONSERVA Y QUÉ SE REFORMULA

QUÉ COMPRENDE	
Se conserva	El procedimiento de rastreo, el catálogo de dipolos y las correlaciones clínicas acumuladas, como referencia estadística
Se actualiza	El fundamento, que pasa a formularse sobre la matriz extracelular, el voltaje de membrana y la interacción entre campo y tejido
Se somete a comprobación	Las 26 reglas heredadas, reescritas como 29 principios que cualquiera puede poner a prueba y refutar

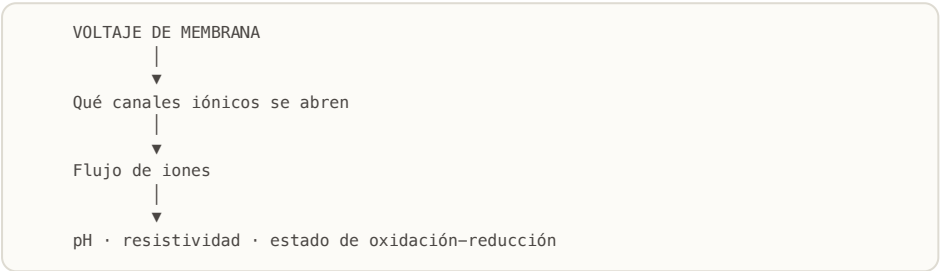
El desplazamiento del pH que observó Broeringmeyer es precisamente el punto que obliga a reformular el fundamento, porque el pH resulta ser una consecuencia y no la variable intervenida. El capítulo siguiente lo establece.

3

El voltaje de membrana

Es la variable que organiza, y el pH es una de sus lecturas.

DEL VOLTAJE AL MEDIO



Las tres variables con las que se describe cualquier medio son el pH, la resistividad y el estado de oxidación-reducción. El pH es una de las tres, y no la variable primaria.

- pH – la concentración de iones hidrógeno, que desplaza el medio hacia lo ácido o lo alcalino.
- Resistividad – cómo se transmite una corriente a través del medio, es decir, con qué facilidad se mueven los iones.
- Estado de oxidación-reducción – si el medio cede o capta electrones.

Las tres se combinan, y esa combinación describe el medio mejor que cualquiera por separado. En medios ácidos y oxidados proliferan los hongos; en medios ácidos y reducidos, los virus.



El microorganismo no produce el estado del medio: el medio facilita su proceso. Esa es la razón por la que el método interroga el microambiente y no busca al agente.

QUÉ MÁS GOBIERNA EL VOLTAJE

Además de esas tres variables, el voltaje de membrana determina el comportamiento del tejido:

FUNCIÓN	CÓMO DEPENDE DEL VOLTAJE
Proliferación o diferenciación	Despolarizada, la célula prolifera. Hiperpolarizada, se diferencia y ejerce su función
Secreción glandular	El voltaje de la glándula regula lo que secreta
Permeabilidad	El voltaje determina qué carga y qué tamaño deja pasar la unión estrecha
Acoplamiento entre células	El voltaje determina si las uniones comunicantes quedan abiertas o cerradas
Motilidad digestiva	El voltaje genera la onda eléctrica que precede a la contracción

Las dos uniones que aparecen en esa tabla son estructuras distintas:

- Unión estrecha. El cierre hermético entre dos células vecinas, que ocluye el espacio que queda entre ellas. Determina qué puede atravesar un epitelio pasando *entre* las células en lugar de a través de ellas. Es lo que hace que un intestino o un endotelio sean una barrera y no un colador.
- Unión comunicante. El canal que conecta el interior de una célula con el interior de la vecina, y que deja pasar iones y moléculas pequeñas de un citoplasma al otro. Es lo que hace que un grupo de células se comporte eléctricamente como un tejido y no como células sueltas.

La unión comunicante es la estructura por la que viaja la información en la que se apoya todo el rastreo. Cuando está abierta, el cambio de voltaje que introduce un imán se propaga a las células vecinas; cuando se cierra, el grupo queda desconectado. Los capítulos 12 y 14 desarrollan las dos consecuencias de ese hecho.

El voltaje instruye por encima del contenido genético. Dos células con idéntico material genético pueden encontrarse en estados bioeléctricos distintos y comportarse de manera distinta. Un patrón bioeléctrico correcto corrige morfología y expresión genética incluso en presencia de una mutación.

En el renacuajo, llevar el voltaje de membrana del muñón de la cola a -30 mV produce la regeneración de la cola.

EL IMÁN ACTÚA SOBRE EL VOLTAJE, Y NO SOBRE EL PH

La técnica trabaja sobre el voltaje de membrana, y las tres variables del medio se desplazan en consecuencia. El campo no modifica el pH de forma directa.

La comprobación es directa: un imán colocado sobre un líquido deja el pH sin cambio y modifica la salinidad.

De la misma jerarquía se sigue una consecuencia para la interpretación de estudios: una analítica de sangre puede permanecer dentro de rango mientras el tejido está desregulado. La sangre promedia el estado de todo el organismo; el rastreo interroga una zona. Son dos mediciones de cosas distintas, y la segunda no se deduce de la primera.

TODAS LAS CÉLULAS SON BIOELÉCTRICAS

La neurona cambia su voltaje en milisegundos, y el resto de las células en minutos o días. Esa es la única diferencia.

La piel, las fascias y las vísceras operan alrededor de -50 mV, y ese voltaje gobierna su comportamiento. Una célula en reposo se sitúa cerca de -70 mV. Un electrodo colocado bajo la membrana registra valores de -10 , -60 o -90 mV según el tejido.

Ese voltaje, sin embargo, no se sostiene en el vacío. Depende del medio que rodea a la célula, y ese medio tiene propiedades eléctricas propias.

4

La matriz extracelular

Tiene carga propia y fija el microambiente del tejido.

EL MEDIO QUE RODEA A LAS CÉLULAS TIENE CARGA MEDIBLE

Se compone de proteoglicanos, colágena y elastina, y es eléctricamente activa, con carga medible.

La cantidad total de proteoglicanos y de cargas del tejido se denomina densidad de carga fija. Determina cuánta agua atrae el tejido y cuánta carga ácida admite antes de saturarse.

Los glicosaminoglicanos aportan grupos carboxilo y sulfato ionizados, que mantienen la carga del medio desplazada hacia lo negativo. Un tejido con carga negativa más densa atrae agua y dispone de más sitios para acomodar cargas.



El organismo excluye el cloro del compartimento intersticial, y de esa diferencia de carga entre el interior y el exterior resulta el potencial de Donnan. Cuanta más capacidad tiene el tejido de acomodar sus cargas, más estable es su microambiente.

El tejido acomoda la carga ácida mientras tiene sitios donde alojarla. Un tejido con esa capacidad conserva su voltaje aunque reciba carga; un tejido saturado la desplaza a los iones que siguen.

EL ORDEN DE MOVILIZACIÓN IÓNICA

Cuando la carga ácida supera la capacidad de eliminación, el tejido moviliza sus iones en un orden fijo, empezando por el de movilización más fácil:

PASO	ION	CONSECUENCIA CLÍNICA
1	Calcio	Se moviliza del hueso, que se vuelve poroso. Aparece osteopenia sin déficit hormonal que la explique
2	Magnesio	Sueño de mala calidad, fatiga muscular, agotamiento
3	Potasio	Último ion antes del compromiso orgánico

El potasio ocupa el último lugar porque es el ion del que depende de forma más directa el potencial de membrana descrito en el capítulo 3. Cuando el tejido llega a movilizarlo, lo que está comprometiendo es la variable que organiza. De ahí que la enfermedad crónica curse con deficiencia de potasio en el tejido.

DÓNDE TERMINA EL ALCANCE DEL MÉTODO

La secuencia es impregnación, después inflamación crónica, y por último degeneración orgánica.

El límite del método está en la última: el daño orgánico establecido queda fuera de su alcance. El capítulo siguiente explica por qué.

5

Clases de agente

El cuerpo es un agente de clase B: se le reescribe el punto de ajuste con un campo magnético.

CUATRO CLASES, SEGÚN CÓMO SE MODIFICAN

CLASE	QUÉ ES	CÓMO SE MODIFICA
A	Estructuras físicas	Solo cambiando la estructura
B	Sistemas con punto de ajuste	Cambiando el punto de ajuste
C	Animales	Por consecuencia: aprendizaje
D	Personas	Por razonamiento

La Regulación Bioeléctrica trabaja sobre agentes de clase B, C y D.

CLASE	EJEMPLO DEL MUNDO	EJEMPLO CLÍNICO
A	Un reloj mecánico	Una fractura
B	Un termostato, una regadera	La inflamación crónica
C	Un animal que aprende por consecuencia	—
D	Una persona que cambia por razonamiento	Una creencia sobre la propia enfermedad

Esta clasificación es la que da forma precisa al límite anunciado en el capítulo anterior. La fractura pertenece a la clase A y por eso queda fuera del método, porque no hay punto de ajuste que reescribir. La inflamación crónica pertenece a la clase B, tiene punto de ajuste, y por eso responde.

CON QUÉ SE ALCANZA CADA CLASE

La clasificación dice qué admite cada agente, y no con qué se le llega. Son dos cuestiones distintas, y en una sesión se emplean dos vehículos.

CLASE	CON QUÉ SE ALCANZA
B	El campo magnético. Reescribe el punto de ajuste del tejido sin modificar la estructura
C y D	La palabra. Los cuatro pasos de conducción y la formulación con la que se le explica la sesión a la persona

El campo magnético llega hasta la clase B y no más allá: lo que un imán modifica es el voltaje de membrana de un tejido, según el capítulo 26.

Lo que alcanza a las clases C y D es lo que el operador dice durante la permanencia. Esa parte del procedimiento tiene su propio capítulo en la Parte II, y también su propio límite: se trabaja la predicción de amenaza que el sistema mantiene, y no el contenido de lo que la persona piensa o siente.



En los términos del capítulo 6, esa distinción se lee sobre los componentes: el campo edita C y reabre O; la palabra alcanza en parte a E, que es la meta que el sistema defiende. H queda fuera de los dos, por la razón que da el capítulo 25.

Un tejido conserva su estado de referencia en un patrón bioeléctrico, que es el voltaje de membrana. El campo magnético modifica ese voltaje y los canales iónicos, y con ello la señal de referencia, sin modificar la estructura y sin administrar ninguna sustancia.

REGULAR ES DEVOLVER LA SEÑAL DE REFERENCIA

El tejido conserva la capacidad de ajustar su propio estado; lo que ha perdido es la señal que le indica cuál es ese estado.

La enfermedad crónica corresponde a una adaptación que dejó de actualizarse: el sistema mantiene un estado que ya no corresponde a la situación presente.

El caso que lo muestra es la inflamación crónica. El macrófago es la célula que limpia y repara un tejido dañado, y trabaja en dos modos sucesivos: primero un fenotipo inflamatorio, en el que destruye, retira restos y llama a más células al sitio; después un fenotipo reparador, en el que deja de destruir, apaga la señal de alarma y organiza la reconstrucción del tejido. La secuencia normal recorre los dos y termina.

En la inflamación crónica los macrófagos continúan en el primer fenotipo porque no han recibido la información de que el proceso terminó. Esa información llega por vía eléctrica, a través del voltaje de membrana. Mientras el voltaje no cambia, el macrófago mantiene su programa.

El costo de mantener puntos de ajuste desplazados se acumula. Cada adaptación que el organismo instala ante una perturbación sostenida deja un costo, y esos costos se suman. Ese acumulado es lo que el método interroga cuando el rastreo da hallazgos repartidos por todo el cuerpo.

LA PREGUNTA DE LA SESIÓN

La pregunta es qué agente perdió su capacidad de regularse y de volver a su función.

Queda por establecer cómo un campo magnético llega a modificar el voltaje de una membrana, dado que no aporta ni cargas ni energía. Es el objeto del bloque siguiente.

6

El sistema que se regula

Qué componentes tiene un sistema con punto de ajuste, y cuáles de ellos se editan.

El capítulo anterior estableció que el cuerpo admite tratarse como agente de clase B y que la intervención consiste en reescribir un punto de ajuste. Falta decir qué es un agente, qué es exactamente un punto de ajuste y de qué partes se compone un sistema que se regula. Sin ese vocabulario, los capítulos de límites no se pueden leer.

QUÉ ES UN AGENTE

Un agente es un sistema que sostiene un estado propio frente a las perturbaciones del medio. No basta con que reaccione: una piedra que se calienta al sol reacciona y no sostiene nada. El agente tiene un estado al que vuelve, y dispone de acciones con las que volver a él.

Un termostato lo es en su forma mínima: mide, compara con una referencia y actúa. Una célula lo es en una forma incomparablemente más rica, y un tejido lo es a su propia escala. Por eso la clasificación del capítulo 5 no es una metáfora: describe qué tipo de intervención admite cada cosa según cómo sostenga su estado.

QUÉ ES UN PUNTO DE AJUSTE

El punto de ajuste es la referencia contra la que el sistema compara su estado actual para decidir si actúa: es el valor con el que el estado se compara, y no el estado mismo.

Un termostato con el punto de ajuste en 20 °C y la habitación a 15 °C enciende la calefacción. Si alguien mueve la referencia a 30 °C, el aparato hace exactamente lo que le corresponde hacer, y calienta de más. No se descompuso el termostato: alguien le movió el número. Para corregirlo no se repara nada, se mueve la referencia.

Esa distinción es la que sostiene todo el método. Un tejido con inflamación crónica no está descompuesto en el sentido de la clase A. Está ejecutando correctamente lo que su referencia le indica, y esa referencia dejó de corresponder a la situación presente. En el tejido, esa referencia está escrita en el voltaje de membrana, que es lo que establecieron los capítulos 3 y 5, y por eso un campo magnético puede reescribirla sin modificar la estructura y sin administrar sustancia alguna.



LOS CINCO COMPONENTES

Describir un sistema como agente exige nombrar por separado lo que puede hacer y la información con la que decide hacerlo. El formalismo que este manual emplea consta de cinco componentes:

$$P = \langle S, \setminus O, \setminus C, \setminus E, \setminus H \rangle$$

LETRA	QUÉ DESIGNA	QUÉ ES	EN EL TEJIDO
S	Estados	Todas las configuraciones que el sistema puede ocupar	Los estados bioeléctricos posibles de ese tejido
O	Operadores	Todo lo que el sistema puede hacer: secretar, captar, movilizar	Las funciones que la célula conserva y puede ejecutar
C	Restricciones	Qué acciones están permitidas en cada estado	Lo que el tejido tiene bloqueado, aunque conserve la capacidad
E	Evaluación	Qué valor defiende el sistema: el criterio interno con el que juzga si va bien	El punto de ajuste
H	Horizonte	Con cuánta anticipación llega la información	Hasta dónde ve el sistema antes de que ocurra la perturbación

Cada operador cuesta. Ese precio se designa con una *w* minúscula y se paga en energía, en nutrientes o en tiempo. No es un sexto componente: va pegado a cada acción del repertorio, y es la razón de que un sistema no ejecute siempre la mejor acción disponible sino la que puede pagar.

De ahí se sigue también el costo acumulado que describió el capítulo 5: cada punto de ajuste desplazado que el organismo sostiene se paga de forma permanente, y esos pagos se suman. Es lo que el rastreo encuentra como hallazgos repartidos por todo el cuerpo.

MAQUINARIA E INFORMACIÓN

La división que hace utilizable el formalismo es esta:

	MAQUINARIA	INFORMACIÓN
Componentes	S, O	C, E, H
Cuando falla	Se repone	Se reescribe
Costo de corregirla	Alto	Bajo

S y O son lo que el sistema es. C, E y H son lo que el sistema cree. Reponer maquinaria exige construir estructura o aportar sustancia. Reescribir información no exige ninguna de las dos cosas, y por eso una intervención que no aporta energía ni materia puede modificar el comportamiento de un tejido.

Aquí se apoya el capítulo 5: la clase A no tiene columna derecha, y por eso queda fuera del método. La clase B la tiene, y por eso responde.

POR QUÉ LAS RESTRICCIONES IMPORTAN MÁS DE LO QUE PARECE

Una restricción no es una falla. Es lo que hace que el problema sea ese problema y no cualquier otro. Un tejido sin restricciones no sería un tejido sano, sería un tejido desorganizado.

SITUACIÓN	CONSECUENCIA
Demasiada restricción	El sistema se rigidifica y queda atrapado en un modo
Restricción insuficiente	El sistema se desorganiza

El problema aparece cuando una restricción se instala para una situación y permanece después de que esa situación terminó. La lectura pregunta si la restricción fue correcta en su momento, no si es correcta hoy.

Y hay una razón por la que la técnica trabaja sobre C y no sobre O:

*Editar una restricción cambia el sistema más que añadir un operador.
Añadir una acción al repertorio amplía lo que el sistema puede hacer de forma lineal. Retirar un bloqueo vuelve alcanzables de golpe todas las rutas que pasaban por ahí, y esas crecen de forma combinatoria.*

EL TRINQUETE

Una restricción ordinaria se puede editar: se retira y la vía vuelve a estar disponible.



El trinquete es la restricción que deja pasar en un sentido y no en el contrario, y por eso no se edita retirándola: el paso de vuelta no existe.

Su forma es siempre la misma: el sistema se defiende cerrando una vía, pasa la amenaza, y la vía sigue cerrada. La defensa fue correcta en su momento y avanzó en un solo sentido.

El operador lo reconoce cuando la zona responde durante la sesión y vuelve al mismo estado entre una sesión y la siguiente, de forma repetida.

EL HORIZONTE ES UNA CONSECUENCIA FÍSICA

H es una consecuencia física de qué información le llega al sistema y con cuánto retraso, y no una cualidad suya. Cortada una línea de información, la anticipación se pierde necesariamente, sin que nada más se haya dañado.

Está calculado en la literatura para organismos completos: una ameba tiene un horizonte de aproximadamente 1 paso, fijado por el tiempo que tarda una molécula en difundir a través de su propio cuerpo; una planaria alcanza unos 22 000, porque su reloj interno es la división celular. Cuatro órdenes de magnitud de diferencia, derivados de constantes físicas medibles.

Esa es la razón de que el capítulo 25 sitúe H fuera del alcance de la técnica: no se edita como una restricción, depende de que exista la vía por la que la información llega.

LOS TRES MODOS DE FALLA

Cuando una función se ejecuta peor, hay tres explicaciones que se parecen en la clínica y piden conductas distintas:

QUÉ FALLÓ	CÓMO SE DISTINGUE	QUÉ CONDUCTA PIDE
w · Subió el precio	La respuesta aparece completa si se aumenta la señal o se baja la demanda	Más señal, o menos carga
C · Se cerró una vía	Esa vía no responde y otra del mismo tejido sí	Editar la restricción, o trabajar por la vía que sigue abierta
Σ · Se perdió el orden entre las partes	Igualadas la señal y la capacidad, las respuestas dejan de ir en orden	Devolverles el ritmo

La regla que se sigue de ahí: si lo que falló es C , mover w no lo toca. Aumentar la señal sobre una vía cerrada no la abre, y sobre un sistema que perdió el orden entre sus partes lo empuja sin coordinarlo.

LA K: CUÁNTO RESUELVE UN SISTEMA

La K compara lo que el sistema consigue contra lo que conseguiría una búsqueda ciega. Es la medida de cuánto se comporta como agente y no como azar. Cero equivale al azar, y cada punto entero agrega un factor de 10.

K	CUÁNTAS VECES MEJOR QUE EL AZAR
0	Igual que el azar
1	10 veces
2	100 veces
3	1000 veces

Un sistema que supera al azar se comporta como agente. Es el criterio con el que se juzga si una zona conserva capacidad de regularse.

Σ: CUÁNTO APORTA ESTAR COORDINADOS

La K se puede calcular para un conjunto y también para cada una de sus partes por separado. La diferencia entre ambas cosas es lo que mide la coordinación:

$$\Sigma_{int} = K_{total} - \sum_j K_j$$

Con $\Sigma_{int} > 0$ el conjunto resuelve mejor que la suma de sus partes: hay algo que solo existe porque están conectadas. Con $\Sigma_{int} = 0$ el conjunto es exactamente esa suma, y la conexión no aporta nada. Sesenta músicos excelentes tocando bien no son una orquesta, y lo que les falta es esto.

Es el tercer modo de falla de la tabla anterior, y el que explica que un tejido cuyas células conservan intactas S y O –saben hacer lo que hacían– pueda aun así funcionar mal. Es también la forma precisa de decir qué pierde el tejido cuando se cierran sus uniones comunicantes, que es la lesión del capítulo 14.

La forma de medir Σ_{int} es una propuesta del equipo docente y no está publicada. El procedimiento para obtener un valor de K a partir de los hallazgos de una sesión tampoco está descrito en este manual. Ninguna de las dos se emplea todavía como medida clínica.



DE DÓNDE VIENE EL FORMALISMO

La formulación clásica, de los años setenta, consideraba únicamente S y O como partes del problema; las otras tres se trataban como decisiones de estrategia. Levin y Chis-Ciure las elevaron a componentes de pleno derecho, con una razón precisa: los sistemas vivos reescriben su propio espacio de problema, además de moverse dentro de él. Se editan las restricciones, se recalibran la meta y se ajustan el horizonte, y esa capacidad de reajustar el propio problema es lo que distingue a la inteligencia biológica.

De ahí sale la pregunta que este manual hereda y que define su objeto:

Qué le ocurre a un sistema que se reescribió el problema, por una buena razón y de forma adaptativa, y después perdió la capacidad de volver a reescribirlo.

Esa es la formulación exacta de la enfermedad crónica que dio el capítulo 5, y es lo que la técnica intenta devolver.

PARA QUÉ SIRVE ESTA DESCRIPCIÓN

Un resultado ausente deja de ser un fracaso indeterminado y pasa a ser una pregunta acotada: qué componente está en conflicto, y si ese componente admite la intervención de la que dispone esta técnica. Los capítulos 24, 25 y 26 la retoman, una vez descritos el procedimiento y sus resultados.

BLOQUE II

El instrumento

Por qué vías actúa el campo, qué intensidad se necesita, hasta dónde llega y con qué dispositivos se alcanza la profundidad.

7

Cómo llega el campo a la célula

El imán no aporta energía: su campo actúa por cuatro vías que convergen en el voltaje de membrana.

UN IMÁN NO APORTA CARGAS NI ENERGÍA

Un imán produce un campo magnético. No contiene cargas eléctricas ni las transfiere al tejido, y no aporta energía.

Los nombres positivo y negativo son una convención posterior. Lo que existe físicamente es el polo norte y el polo sur, por referencia a la brújula.

Un polo magnético no destruye microorganismos.

LAS CUATRO VÍAS

	MECANISMO	QUÉ OCURRE	EN CUÁNTO TIEMPO
1	Anisotropía diamagnética	El campo produce un torque sobre los fosfolípidos de la bicapa de la membrana. Esa deformación cambia la geometría del canal iónico y el canal se abre. Se demuestra con patch clamp: al colocar el imán, el cambio de voltaje aparece de inmediato	Segundos
2	Canales de calcio tipo T	El calcio actúa como mensajero intracelular. El campo modifica el flujo por estos canales	De minutos a horas
3	Magnetita biogénica	Cristales ferromagnéticos presentes en membranas y en tejido nervioso sufren torque y ejercen tracción sobre el citoesqueleto. Al menos 5 millones de cristales por gramo de tejido	—
4	Fenotipo del macrófago	El campo favorece el desplazamiento del macrófago del fenotipo inflamatorio al reparador	—



Los cuatro convergen en el voltaje de membrana, y esa convergencia los reúne en un solo efecto en la práctica. El polo interviene únicamente en el primero, el torque; no hay datos que documenten efectos distintos del polo negativo y del positivo por otra vía.

EL CAMPO MUEVE LOS IONES MENOS QUE LA ENERGÍA TÉRMICA DEL ORGANISMO

Un imán clínico de 100 a 500 mT produce sobre los iones una energía inferior a la energía térmica del organismo: un cuadro febril moviliza los iones más que el campo del imán.

Por eso el efecto observable requiere estructuras supramoleculares organizadas en la membrana, que es donde actúa la fuerza de Lorentz, la que un campo magnético ejerce sobre una carga en movimiento. El campo no desplaza iones de forma directa.

De ahí que aumentar la intensidad no aumente el efecto. Si el mecanismo dependiera de mover iones por fuerza bruta, un imán más potente rendiría más. Como depende de la geometría de la membrana, lo que cambia el resultado es el gradiente y el sitio de colocación.

Establecido que la intensidad no decide el resultado, queda por saber cuánta se necesita y hasta dónde llega. Es lo que fija el capítulo siguiente.

8

Intensidad y alcance

El neodimio de 300 a 500 mT alcanza unos 2 cm, y un imán más intenso no mejora el resultado.

UNIDADES

La densidad del campo se expresa en gauss o en tesla. 1 T equivale a 10 000 G. El gaussaje cuenta líneas de fuerza por centímetro cuadrado. La literatura de investigación emplea el tesla, y este manual expresa todas las intensidades en militesla.

FERRITA Y NEODIMIO

PROPIEDAD	FERRITA	NEODIMIO
Intensidad de superficie	100 a 300 mT	300 a 500 mT
Comportamiento térmico	Estable	Pierde magnetismo por encima de 80 °C
Resistencia mecánica	Frágil al impacto	Frágil al impacto
Uso	Versátil, costo bajo	Estándar clínico actual

Los imanes de neodimio se atraen entre sí con fuerza y se fracturan al chocar. Se usan cubiertos y con lengüeta para retirarlos.

LA VENTANA DE RESPUESTA DEL TEJIDO

FUENTE	INTENSIDAD
Campo magnético terrestre	0.05 mT
Imán de refrigerador	5 mT
Ventana en la que el tejido responde	2 a 80 mT
Imanes estáticos de uso clínico	100 a 500 mT
Resonancia magnética	1500 a 3000 mT

El imán clínico entrega en la superficie una intensidad muy superior a la ventana de respuesta. Lo que llega al tejido objetivo es una fracción, porque la densidad del campo decae con la distancia.

PROFUNDIDAD

Un imán de neodimio de 2.5 cm de diámetro alcanza unos 2 cm de profundidad. Los órganos profundos rara vez reciben campo suficiente por colocación directa; para ellos se emplea el imán de bocina o la placa de gradiente del capítulo 10.

Aquí se aplica de forma directa la conclusión del capítulo 7: un imán de mayor intensidad no compensa un sitio equivocado. Lo que determina el efecto es la densidad en el nodo correcto, y el nodo lo determina el rastreo.

TAMAÑO

El tamaño del imán corresponde al de la zona que se busca. Un imán mayor que la zona no delimita el hallazgo: si abarca más superficie que la isla, no la localiza.

**EL TEJIDO DEL ORGANISMO ES DIAMAGNÉTICO**

COMPORTAMIENTO	QUÉ SIGNIFICA	EJEMPLO
Ferromagnético	Sensible al campo y magnetizable, por tener electrones no apareados en la última capa	Hierro
Paramagnético	Sin respuesta apreciable	Aluminio, madera, tela
Diamagnético	Sensible al campo y no magnetizable	Agua, y el tejido del organismo

9

El gradiente

El efecto lo produce el gradiente entre dos polos opuestos, y no la intensidad de un imán.

Si la intensidad no decide y el tamaño solo delimita, queda por identificar qué variable del instrumento sí determina el efecto. Es el gradiente.

DÓNDE ALCANZA SU VALOR MÁXIMO

El gradiente alcanza su valor máximo en la frontera entre dos polos opuestos y adyacentes. Dos imanes colocados juntos, con polos contrarios enfrentados, generan lo que se denomina gradiente empinado.

CUÁNDO SE COLOCA EL SEGUNDO POLO

Cuando un imán solo deja la medición sin cambio, se coloca el segundo. El efecto lo produce el gradiente entre ambos, y no la intensidad de uno de ellos.

Un imán de mayor intensidad no reemplaza al segundo polo.

EFFECTO SOBRE LA FIBRA NERVIOSA

El gradiente empinado modifica el flujo de sodio y de calcio en la fibra nerviosa, con reducción de la transmisión.

Condición de colocación: los dos imanes se mantienen juntos, en posición de atracción. Al separarlos, el gradiente deja de ser empinado y el efecto se pierde.

DOS MODOS DE TRABAJO

MODO	CÓMO SE COLOCA	PARA QUÉ
Sobre el lugar	Los dos polos en la misma zona, en gradiente empinado o focal	Dolor de la zona, y reorganización local del voltaje
Sobre el sustrato	Un polo en la zona y el otro en un nodo distante	Cuando el disturbio compromete una escala mayor que la zona

El nodo distante principal es el riñón, por la razón que da el capítulo 15.

10

Dispositivos de profundidad

El imán de bocina y la placa de gradiente llegan a los órganos profundos.

Los 2 cm de alcance del capítulo 8 dejan fuera a la mayoría de los órganos internos. Los dos dispositivos que siguen resuelven ese límite generando el gradiente dentro de una sola pieza.

EL IMÁN DE BOCINA

En el imán de bocina los dos polos están en la misma cara: el centro corresponde a un polo y el borde al contrario. Una sola pieza genera por sí misma un gradiente, de alrededor de 4 cm de alcance.

Se usa siempre la cara donde están los dos polos.

PRUEBA DE POLARIDAD DEL IMÁN DE BOCINA

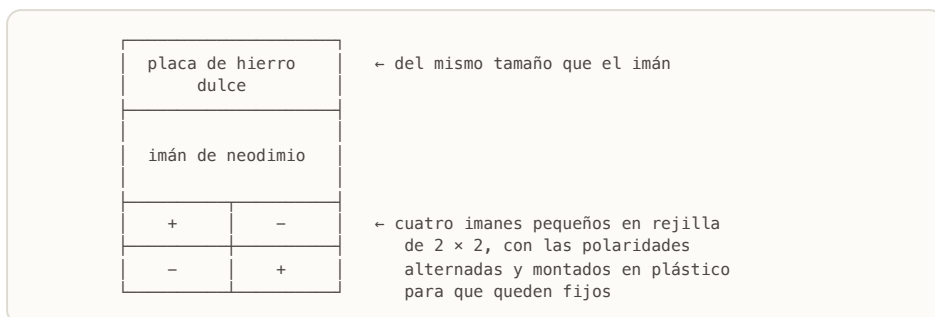
- 1 · Se coloca un imán pequeño sobre el CENTRO de la pieza.
Se atrae → el centro es el polo negativo.
Se repele → el centro es el polo positivo.
- 2 · Se desplaza el imán pequeño hacia el BORDE.
El comportamiento se invierte, lo que confirma
que los dos polos están en la misma cara.
- 3 · El polo del CENTRO es el que se coloca contra la piel
en el nodo que se está rastreando.

La polaridad que actúa es la del centro de la pieza. Cuando el procedimiento pide polo negativo sobre la zona —el paso 2 del capítulo 15 y el paso 2 del capítulo 52—, se emplea una bocina cuyo centro sea el polo negativo, comprobado con la prueba anterior. El borde queda con la polaridad contraria y forma el gradiente, sin que haya que colocar nada más.

En los imanes forrados en dos colores, el negro corresponde al polo negativo y el rojo al positivo. Esas piezas también llevan gradiente propio, y la cara opuesta queda sin función en esta técnica.

Los imanes de bocina se obtienen de bocinas desarmadas, o se compran ya sueltos.

LA PLACA DE GRADIENTE



- 01 Un imán de neodimio de la medida que corresponda a la zona.
- 02 Una placa de hierro dulce del mismo tamaño, sobre la cara superior.
- 03 Cuatro imanes pequeños en rejilla por debajo, incrustados en plástico para que conserven su posición.

Las polaridades de la rejilla inferior alternan, de modo que al menos dos de los cuatro imanes queden en polaridad contraria a la del imán principal. Esa alternancia es la que genera el cambio de gradiente.

El gradiente alcanza unos 6 cm de profundidad, y con ese alcance se trabaja sobre órganos que quedan fuera del alcance de un imán simple.

UNA CUESTIÓN ABIERTA SOBRE EL POLO DE RASTREO

El rastreo se ejecuta por tradición con el polo negativo. El polo positivo también produce acortamiento en algunas colocaciones, y el mecanismo por el que el negativo quedó fijado como polo de rastreo no está establecido.

Descrito el instrumento, el bloque siguiente introduce el vocabulario con el que se nombra lo que el instrumento encuentra, y el procedimiento con el que se lee.

BLOQUE III

Vocabulario y lectura

Cómo se nombra lo que el rastreo encuentra, por qué el cuerpo responde con un acortamiento, cómo se mide y qué es una isla bioeléctrica.

11

Nodo y dipolo

Se dice nodo, y dos nodos de la misma red son un dipolo.

LOS DOS TÉRMINOS

Se denomina nodo al lugar donde el rastreo produce respuesta. El término sustituye a la denominación anterior de punto.

Dos nodos de la misma red forman un dipolo. El término sustituye a la denominación anterior de par.

TIPO DE NODO	DÓNDE SE LOCALIZA
Nodo local	En el mismo lugar donde se encuentra el disturbio
Nodo distante	En una zona que no coincide con donde hay dolor o lesión

Lo que determina el resultado es que el imán encuentre el nodo de la red al que ese disturbio pertenece.

POR QUÉ DOS NODOS DISTANTES SE RELACIONAN

Que un nodo situado lejos de la molestia restablezca la simetría exige una explicación anatómica. Cuatro continuidades la sostienen:



CONTINUIDAD	QUÉ LA SOSTIENE
1 El paquete neurovascular	Todo nervio viaja acompañado de un vaso, y los paquetes convergen en territorios funcionales
2 La matriz extracelular	Forma una red continua en todo el organismo, descrita en el capítulo 4
3 El acoplamiento celular	Ninguna célula opera aislada. Las que se aíslan tienen vida corta y función restringida
4 Los territorios linfoides asociados a mucosas	Agrupar tejido inmune de regiones distantes bajo una misma regulación

Las cuatro continuidades están documentadas; su uso como explicación de los dipolos distantes es una lectura de este método.

LAS TRES GEOMETRÍAS DEL DIPOLO

GEOMETRÍA	CÓMO SE COMPONE	QUÉ INTERROGA
Dipolo local	Los dos imanes sobre la misma zona, adyacentes	El lugar
Dipolo distante	El nodo hallado con su regulador: riñón, suprarrenal, hígado o bulbo	La escala a la que pertenece el disturbio
Dipolo transversal	El nodo con su homólogo contralateral	El estado general del cuerpo

Nombrado el hallazgo, queda por explicar cómo se detecta. El capítulo siguiente describe el indicador.

12

El indicador

El músculo iliopsoas transmite el cambio de voltaje, y la extremidad izquierda es la referencia.

POR QUÉ EL ILIOPSOAS

El iliopsoas se origina en la segunda vértebra lumbar y se inserta en el fémur. Tiene inervación dual y continuidad anatómica con el diafragma, la fascia toracolumbar y la cadena simpática.

Esa inervación dual y esa continuidad lo hacen sensible al estado autonómico, y por eso es el músculo que el método usa como indicador.

Cuando el imán produce un cambio de voltaje en una zona, esa información se propaga por el gradiente del tejido a través de las uniones comunicantes, que conectan a las células entre sí sin solución de continuidad. La respuesta se manifiesta como un cambio de tono en el iliopsoas, que se observa como acortamiento de la extremidad.

El acortamiento es un cambio de tono muscular, y no un acortamiento óseo. Se estudió con radiografía: en alrededor del 4 % de los casos existe una discrepancia real de longitud. La resonancia magnética funcional documentó el cambio en el iliopsoas al modificarse el patrón bioeléctrico.

De aquí se sigue una advertencia de interpretación: la extremidad no contiene información sobre la zona interrogada. Lo que se lee es la respuesta del sistema completo a la perturbación que introduce el imán.

POR QUÉ LA IZQUIERDA ES LA REFERENCIA

En cada latido el corazón emite un campo electromagnético con dirección e intensidad definidas, y en el electrocardiograma normal el eje eléctrico se orienta hacia la izquierda.

Por esa razón la extremidad izquierda es la referencia y la derecha es la variable, en todas las mediciones de la sesión.

Excepciones documentadas: dextrocardia, y algunas anomalías cardíacas con soplo, entre ellas la tetralogía de Fallot.

La extremidad que acorta es generalmente la derecha, que es la variable. El procedimiento consiste en dejar que el reflejo ocurra sin que el operador lo induzca: un acortamiento provocado por la tracción de quien mide no corresponde a un hallazgo.

EL APRENDIZAJE DEL SIGNO

La lectura del acortamiento pide alrededor de 100 exploraciones antes de incorporar otras formas de lectura. Se coloca el imán y se mide, de forma repetida, hasta desarrollar sensibilidad al fenómeno.

13

La medición

Solo es comparable si se repite igual en cada colocación.

Si la referencia cambia entre una medición y la siguiente, las lecturas dejan de ser comparables y el rastreo pierde su valor. De ahí que el procedimiento esté fijado paso a paso.



PREPARACIÓN

- 1 · **EXPLICAR EL PROCEDIMIENTO**
Se informa que consiste en una evaluación de simetría y una colocación de imanes, indolora y no invasiva.
- 2 · **RETIRAR OBJETOS**
Joyas, reloj, cinturón, llaves y dispositivos electrónicos.
- 3 · **POSICIÓN**
Decúbito supino, cabeza en posición neutra, sin hiperextensión.
- 4 · **LIBERAR EL ILIOPSOAS**
Ambas extremidades inferiores se traccionan con suavidad para relajar la articulación pélvica, y después se movilizan hacia los lados para relajar el piso pélvico.
- 5 · **CUBRIR**
Se cubre a la persona con una manta.

POSICIÓN DE MEDICIÓN

POSICIÓN DE MEDICIÓN

Los pies quedan por fuera del borde distal de la camilla, con los talones libres. De preferencia con calzado.

Antes de medir, unas respiraciones profundas.

Ambas extremidades se elevan por los tobillos unos 30 GRADOS, alineadas con el eje del cuerpo.

Los brazos permanecen relajados. La punta del pie queda alineada con la rodilla; los pies pueden abrirse ligeramente.

SE LEVANTA Y SE MIDE. No se tracciona en ese momento y no se corrige nada.

LA CAMILLA

La camilla no lleva superficie metálica, y su altura coincide con la cintura del operador, para que la medición se repita sin esfuerzo.

QUÉ DECIDE LA MEDICIÓN BASAL

HALLAZGO EN LA MEDICIÓN BASAL

QUÉ SIGUE

Extremidades isométricas

Se pasa directamente al rastreo por zonas

Acortamiento funcional

Se establece primero la línea base: corresponde al eje de acidosis, Parte II

Dos situaciones producen acortamiento sin imán colocado: una discrepancia real de longitud por traumatismo previo, o el fenómeno bioeléctrico de acidosis.

Cuando con el imán colocado la extremidad continúa acortada por una discrepancia anatómica propia de la persona, esa longitud se registra como línea base de la sesión.

14

La isla bioeléctrica

Es tejido que cerró sus uniones comunicantes.

El capítulo 12 estableció que la señal viaja por las uniones comunicantes. Queda por describir qué ocurre cuando ese acoplamiento se interrumpe, porque es la lesión característica que el rastreo encuentra.

CÓMO SE FORMA

- 1 · El traumatismo rompe membranas celulares.
- 2 · El potasio intracelular sale al espacio extracelular.
La concentración pasa de alrededor de 4 mmol a valores de 20 a 40 mmol en la zona.
- 3 · Ese exceso de potasio despolariza a las células vecinas.
- 4 · La despolarización cierra las uniones comunicantes, y el grupo de células queda desconectado de la red.

La señal viaja por la red y no entra a la isla. Las células conservan su estructura y su capacidad de trabajo, y lo que pierden es la información de qué posición ocupan en el gradiente del tejido.

Esto ordena la relación con el pH que el capítulo 3 ya había desplazado de la posición primaria: el pH ácido de la zona aparece después, como consecuencia del aislamiento, y no como su causa.

QUÉ LA ORIGINA

Un golpe, una herida, una extracción dental, una intervención quirúrgica o un traumatismo. También la exposición a un fármaco o a un agente químico.

El hallazgo se define por la respuesta, y no por el antecedente. Si la medición no cambia, no hay isla bioeléctrica en esa zona.



CÓMO SE DELIMITA

Se desplaza el imán por la zona y se mide en cada posición. Donde el acortamiento desaparece, termina la isla. El contorno resultante se marca sobre la piel y se traslada al expediente, en dibujo o en fotografía, para volver a interrogar esas mismas zonas en la sesión siguiente.

Las islas de origen antiguo pueden reaparecer en sesiones posteriores, en función de la edad, el estado nutricional y la carga acumulada.

Marca el contorno la propia persona siempre que sea posible. Trazar el propio mapa mantiene a la persona como sujeto de la sesión.

TRES SEÑALES QUE APARECEN CON EL IMÁN COLOCADO

- 01 Movimientos oculares rápidos, como los del sueño. No hace falta llegar a ese nivel para que la sesión sea válida.
- 02 Somnolencia o relajación profunda. La persona se duerme con frecuencia.
- 03 Cambios en la voz, que se arrastra o baja de volumen.

Identificada la isla bioeléctrica y las señales que la acompañan, queda por establecer con qué regla se busca el lugar donde colocarla y con qué criterio se cierra el hallazgo. Es el objeto del bloque siguiente.

BLOQUE IV

El procedimiento

La regla única de rastreo, la lectura del nivel en el que se resuelve el hallazgo, la rejilla y los tiempos de aplicación y retiro.

15

La regla del rastreo

Nodo local, y si no nivela, el orden fijo del nodo distante.

Con el vocabulario del capítulo 11, el indicador del 12 y el procedimiento de medición del 13, la búsqueda queda reducida a una sola regla.

Esta regla se aplica igual en todos los ejes de la Parte II. Lo que cambia de un eje a otro son las zonas que se interrogan y, en dos casos, el orden del nodo distante.

LA SECUENCIA

- 1 · LA ZONA
- Se elige la siguiente zona del eje que se está trabajando, en el orden que ese eje establece.
- 2 · INTERROGAR
- Polo negativo, cara negativa a la piel, sobre la zona.
Con imán de bocina, el centro negativo contra la piel.
Medir la simetría.
- Acorta → zona confirmada. El imán queda fijo.
- Sin cambio → se desplaza el imán dentro de la zona y se vuelve a medir.
- Sin cambio en toda la zona → se pasa a la zona siguiente.
- 3 · DIPOLO LOCAL
- Sin mover el negativo, se prueba el positivo en posiciones adyacentes: a un lado, arriba, abajo. Se mide en cada una.
- Isométricas → dipolo local. Se deja colocado.
- Sin isometría → paso 4.



CONTINÚA

4 · NODO DISTANTE, POR EL ORDEN FIJO

El negativo permanece sobre la zona. Se retira el positivo probado al lado y se sigue la secuencia, midiendo en cada paso:

1. Riñón derecho
2. Riñón izquierdo
3. Suprarrenal derecha
4. Suprarrenal izquierda
5. Hígado
6. Bulbo raquídeo
7. Rastreo del resto del cuerpo

Se detiene en el primero que restablece la isometría.

5 · TIEMPO

Ver capítulo 18.

Una zona que no acorta no se trabaja. La zona la propone el operador a partir del mapa; el nodo lo confirma la medición.

POR QUÉ ESE ORDEN

NODO	FUNCIÓN QUE REPRESENTA
Riñón	Nodo regulador principal. Es el único órgano que regula los iones de todo el organismo, y un cambio de 1 mmol produce desequilibrio bioeléctrico en tejidos distantes
Suprarrenal	Efector neuroendocrino
Hígado	Efector metabólico
Bulbo raquídeo	Control autonómico central

El riñón encabeza la secuencia porque el capítulo 4 estableció que la movilización iónica es el mecanismo por el que un tejido pierde su voltaje, y el riñón es el único órgano que regula los iones del organismo entero.

El último nodo de la secuencia es el bulbo raquídeo, y ese límite se declaró provisional.

DÓNDE SE COLOCA CADA NODO DISTANTE

NODO	REFERENCIA SOBRE LA PIEL
Zona renal, derecha e izquierda	Ángulo costovertebral, entre el borde inferior de la duodécima costilla y el borde lateral de los músculos erectores. La zona renal derecha queda un través de dedo más baja que la izquierda
Suprarrenal, derecha e izquierda	Un través de dedo por encima de la zona renal del mismo lado, en el mismo ángulo costovertebral. Corresponde a la localización de la glándula sobre el polo superior del riñón
Hígado	Hipocondrio derecho, sobre la parrilla costal, de la línea medioclavicular a la axilar media. Se rastrea toda la zona
Bulbo raquídeo	Línea media posterior, en la depresión entre la protuberancia occipital externa y el arco posterior del atlas

Las referencias son de anatomía de superficie, y se comprueban con la mano antes de colocar.

PRECISIÓN SOBRE EL RIÑÓN

Colocar imanes sobre el riñón no regula el potasio del organismo. El riñón es un nodo regulador del voltaje de membrana asociado a esa variable. El potasio tiene su propio punto de ajuste.

CUANDO LA SECUENCIA COMPLETA NO NIVELA

Agotados los seis nodos distantes y el rastreo del resto del cuerpo, el disturbio no pertenece a la escala que este eje interroga. El operador registra el hallazgo, deja el nodo local sin dipolo y pasa al eje siguiente, según el criterio de selección de la Parte III.

Un rastreo sin hallazgos también es información, y se anota como tal.

16

Lectura del nivel

El nivel donde el dipolo restablece la isometría indica la escala del disturbio.

La secuencia del capítulo anterior no solo localiza: al detenerse en un nodo determinado, informa de la escala a la que pertenece el proceso.



DÓNDE NIVELA	QUÉ INDICA
Local	Isla bioeléctrica acotada al lugar donde se encontró
Riñón	Inflamación de origen externo que elevó el punto de ajuste del órgano; con frecuencia, un proceso infeccioso
Suprarrenal	Carga de estrés prolongada. Corresponde a un conflicto neuroendocrino
Hígado	Punto de ajuste del intestino, y también infección crónica
Bulbo raquídeo	Horizonte, en el sentido del capítulo 6: cambio en la capacidad de anticipación del sistema

Un hallazgo que nivela en local corresponde a un cuadro del día o de origen reciente. Un hallazgo que requiere subir por la secuencia compromete al menos un órgano más.

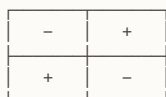
Esta es la lectura que el manual adopta y la que se usa en los ejes de la Parte II. Existe una segunda descripción de los mismos nodos, de carácter mecánico, que los designa como efector iónico, efector neuroendocrino, efector metabólico y control central; procede del material del Módulo 2 y es compatible con la anterior, pero describe la función del órgano y no la escala del proceso. En la sesión se interpreta con la lectura de escala.

17

La rejilla

Se monta sobre un nodo ya confirmado.

MONTAJE



Cuatro imanes iguales entre sí,
en cuadro de dos por dos,
con las polaridades alternadas.

Cada imán queda opuesto a sus vecinos de lado y de arriba; los dos de cada diagonal comparten polo. Si al armarla quedan dos caras iguales juntas, la rejilla está mal montada y se rehace.

La rejilla se monta ceñida al nodo que el rastreo ya confirmó, y sin mover el imán que lo confirmó.

CUÁNDO SE INDICA

- 01 Dolor, inflamación o irritación en la zona.
- 02 Panículo adiposo abundante, cuando el espesor del tejido interpuesto reduce la densidad del campo que llega al objetivo.

SOBRE QUÉ ACTÚA

La rejilla multiplica las fronteras entre polos opuestos, y con ello los gradientes empinados del capítulo 9. Actúa sobre tres estructuras de la zona: la fibra nerviosa, con reducción del componente de dolor por inflamación del nervio; la circulación local; y los macrófagos presentes en el tejido.

LAS FORMAS DE GENERAR GRADIENTE EMPINADO

FORMA	ALCANCE
Varios cambios de polaridad en una superficie pequeña (rejilla)	Superficial
Dos imanes muy próximos, en atracción	Superficial
Imán de bocina	Alrededor de 4 cm
Placa de gradiente	Alrededor de 6 cm

VARIANTE COMBINADA

Cuando el nodo confirmó como dipolo distante, la rejilla se monta sobre el polo negativo y ese dipolo se mantiene. Se trabajan así los dos componentes a la vez: el local y el sistémico.

18

Tiempo y retiro

El reloj dice cuándo se comprueba, y la medición decide si la sesión termina.

EL PROMEDIO ES DE 20 MINUTOS

SITUACIÓN	TIEMPO
Cada zona confirmada	20 minutos de promedio
Acidosis, según el capítulo 27	15 a 20 minutos
Aplicación domiciliaria	No más de 30 minutos por sesión



Esos tiempos corresponden a lo que el tejido tarda en desplazar su voltaje de membrana con el gradiente colocado.

El reloj no retira el imán: indica cuándo se comprueba. Cumplidos los 20 minutos se ejecuta la verificación, y es su resultado el que decide.

LA VERIFICACIÓN DE RETIRO

VERIFICACIÓN DE RETIRO

Cumplidos los 20 minutos, se retira ÚNICAMENTE el polo positivo y se mide.

Isométricas → la zona se resolvió. Se retira también el negativo y la sesión termina.
Vuelve a acortar → se recoloca el positivo y se prolonga. Se repite hasta que, al retirarlo, las extremidades queden isométricas.

LO QUE MANDA ES LA MEDICIÓN

El tiempo es un promedio, y la isometría al retirar el positivo es el criterio de cierre.

QUÉ OCURRE DESPUÉS DE LA SESIÓN

Lo que la sesión produce es el cambio de estado bioeléctrico. La reparación del tejido es consecuencia de ese cambio, ocurre en las horas y los días siguientes, ya sin el imán colocado, y toma su propio tiempo.

De ahí que la mejoría inmediata no confirme el resultado. Lo que se modificó fue un punto de ajuste, y un punto de ajuste se comprueba por su permanencia. El capítulo 22 convierte esto en la pregunta de apertura de la sesión siguiente.

FRECUENCIA Y SERIE

La aplicación puede repetirse a diario, sin exceder los 30 minutos, o cada tercer día. Cuando la persona no puede volver, se le entregan los imanes para aplicación domiciliaria sobre los nodos ya confirmados.

Si un nodo sigue marcando en la segunda y la tercera sesión, se prolonga la serie.

Una sesión no agota el mapa. Al resolverse los nodos de mayor respuesta, en la sesión siguiente aparecen otros que antes no marcaban. La serie continúa mientras el rastreo siga dando hallazgos.

Esa progresión es la razón por la que el registro del capítulo 22 importa: sin el mapa de la sesión anterior, el operador no distingue un nodo nuevo de uno que ya trabajó.



BLOQUE V

Seguridad y derivación

Qué obliga a valorar antes de colocar, qué obliga a derivar sin rastrear y qué corresponde a atención médica inmediata. Este bloque se aplica antes que cualquier otro contenido del manual.

19

Situaciones que obligan a valorar

Marcapasos, embarazo, prótesis y tratamiento oncológico.

Se revisan antes de cualquier colocación:

SITUACIÓN	CONDUCTA
Marcapasos	Valorar. No se colocan imanes en tórax
Embarazo	Se evita el abdomen
Prótesis	Valorar según material y localización
Tratamiento oncológico	El procedimiento se realiza únicamente una vez finalizado el tratamiento. Durante la quimioterapia y mientras el tratamiento siga en curso, no se rastrea ni se colocan imanes

Las tres primeras no prohíben por sí solas la sesión: obligan a valorar y a ajustar la colocación. El tratamiento oncológico en curso sí la difiere, y en ese caso se aplica además lo previsto en el capítulo 20.

20

Hallazgos que obligan a derivar

Nueve situaciones en las que se deriva de entrada, sin rastreo y sin imanes.

Ante cualquiera de estos hallazgos, el operador deriva al médico sin rastrear:

- 01 Dolor agudo intenso, en particular acompañado de vómito.
- 02 Dolor que despierta por la noche de forma persistente.
- 03 Alteración de los esfínteres.
- 04 Inicio en mayores de 50 años atribuido a una causa mecánica.
- 05 Pérdida de peso sin explicación.
- 06 Fiebre acompañada de dolor.
- 07 Déficit neurológico progresivo.
- 08 Cáncer activo o tratamiento oncológico en curso, por posibilidad de compresión. El procedimiento se retoma únicamente una vez finalizado el tratamiento, conforme al capítulo 19.
- 09 Dolor visceral agudo.

Los puntos 1 a 7 y el 9 corresponden a signos que pueden encubrir un proceso que requiere estudio médico. El punto 8 corresponde a una contraindicación temporal, no a un signo de alarma.

21

Urgencias

Sangrado, dolor agudo, crisis convulsiva e infección con fiebre van primero a atención médica.

A diferencia del capítulo anterior, que enumera hallazgos de la valoración inicial, este recoge situaciones en curso que interrumpen o impiden la sesión.

- 01 Sangrado activo.
- 02 Dolor agudo masivo.
- 03 Crisis convulsiva en curso.
- 04 Infección aguda con fiebre.

El operador deriva al médico. La técnica se aplica con el cuadro ya controlado.



BLOQUE VI

Registro y método de trabajo

Qué se documenta antes y después de la sesión, y con qué disciplina se formulan las preguntas del rastreo.

22

La ficha y el mapa de sensaciones

Se registran antes de rastrear.

ESTRUCTURA DE LA FICHA

APARTADO	CONTENIDO
----------	-----------

Subjetivo	Datos de identificación, motivo de consulta y síntomas en el lenguaje de la persona, tratamientos previos, medicación, y el cribado del capítulo 19
Objetivo	El mapa corporal, anterior y posterior
Valoración	Los nodos hallados en el rastreo
Plan	Las técnicas aplicadas y el seguimiento previsto

EL MAPA CORPORAL

Se registra antes de colocar el primer imán.

Se revisa el cuerpo de arriba abajo –cabeza y cara, mandíbula, cuello, hombros, brazos, manos, tórax, abdomen, columna, cadera, piernas, rodillas, pies– y en cada zona se pide una calificación.

ESCALA DEL MAPA

0 = no hay sensación
10 = molestia máxima

Se registra el lado, derecho o izquierdo, cuando difieren.

Entran en el mapa: dolor, tensión, contractura, edema, ardor, molestia inespecífica, y toda zona lesionada en el pasado aunque hoy no produzca molestia.

Cero significa que no hay sensación, y eso también es información: una zona sin sensación registrada no equivale a una zona en buen estado. Si la persona no da una cifra, esa ausencia también se anota.



Se completa con los signos observables: boca seca o húmeda, frecuencia del pulso, respiración, y temperatura y color de las manos.

EL CIERRE DE LA SESIÓN

Al cerrar se revisa el mismo mapa y se comparan las cifras. Se formulan las preguntas de integración: qué diferencias nota, cómo se siente, qué ha cambiado.

Esas preguntas forman parte del procedimiento y no son cortesía. El sistema ajusta su punto de ajuste a partir de diferencias registradas, y una diferencia que la persona no nota no entra en ese ajuste. La diferencia se anota aunque sea de un punto.

Las zonas que no bajaron de calificación se anotan como tales. Corresponden a un nivel distinto del que trabaja esta técnica, en el sentido que precisa el capítulo 24.

LA PREGUNTA DE LA SESIÓN SIGUIENTE

Por lo establecido en el capítulo 18, lo que se comprueba no es el alivio sino su permanencia. De ahí que la sesión siguiente abra con una sola pregunta: cuánto le duró. Es el dato que informa sobre la estabilidad del cambio.

23

Disciplina del rastreo

Una variable por pregunta, predicción antes de la medición, y registro de la trayectoria completa.

1 · Una variable por pregunta. Rastrear a una persona sin acotar el tema equivale a interrogar muchas variables a la vez. Se empieza por un tema definido –por ejemplo, el nodo de lesión– y ese tema es la pregunta de esa serie de mediciones.

2 · Prededir antes de comprobar. Se enuncia en voz alta qué se espera encontrar, y después se mide.

3 · Saber qué se está haciendo. Cada tema que se trabaja requiere conocer la técnica que le corresponde y respetar el catálogo. La ejecución sin criterio produce hallazgos que no se pueden interpretar.

4 · Apoyar cada predicción en sus tres fuentes: lo ya comprobado en literatura, la base teórica disponible, y los casos clínicos registrados.

5 · Repreguntar de otra forma cuando la respuesta es ambigua, y cambiar de nivel cuando el nivel se agota. Insistir sobre la misma colocación no aporta información nueva.



6 · Registrar la trayectoria, y no solo el desenlace. Lo que se anota es la secuencia completa de mediciones, incluidas las que no produjeron respuesta.

Lo que distingue a un operador es qué pregunta sabe formular y en qué orden. La técnica consiste en hacer preguntas con un imán.

Y una regla de control: si en algún momento de la sesión el operador no sabe por qué está haciendo lo que hace, es porque se omitió una medición.

BLOQUE VII

Los límites de la técnica

Qué significa la ausencia de respuesta, cómo se sitúa el hallazgo en la organización del dolor, sobre qué componentes del sistema opera la técnica, y cuál es la regla que resume el instrumento.

24

Niveles del dolor

Que la zona duela sin que la medición cambie, y que el nodo nivele sin que el dolor ceda, señalan niveles distintos.

El capítulo 15 previó el caso en que la secuencia completa no nivela. Este lo interpreta.

LA AUSENCIA DE RESPUESTA

La ausencia de respuesta no indica ausencia de daño. Indica que el mecanismo que produce ese dolor opera en un nivel distinto del que esta colocación interroga.

El caso inverso se lee igual: si el nodo nivela y el dolor continúa, el componente local se resolvió y el proceso está en un nivel superior.

LOS CUATRO NIVELES

El dolor no se produce en un solo lugar. Se construye en cuatro niveles sucesivos, cada uno con su propia forma de sostenerlo:



NIVEL	DÓNDE OCURRE	QUÉ CONTIENE
1 · Tejido	En la zona misma	Sensibilización periférica: las terminaciones nerviosas del sitio bajan su umbral y disparan con estímulos que antes no dolían. Es el nivel donde trabaja esta técnica
2 · Segmento	En la médula espinal	Integración en el asta dorsal, donde convergen las señales de un mismo segmento corporal. Es la razón de que el dolor se extienda a zonas vecinas que no están lesionadas
3 · Modulación	Desde el tronco encefálico hacia abajo	Control descendente: el sistema nervioso central amplifica o atenúa la señal que sube. Cuando esa modulación se desregula, el mismo estímulo produce más dolor
4 · Red	En la organización central	El dolor sostenido por la representación aprendida del cuerpo, con independencia del estado del tejido

Que la técnica trabaje el primer nivel es la consecuencia de que lo que un imán modifica es el voltaje de membrana del tejido, según el capítulo 26.

Cuando los hallazgos no ceden con esta técnica, el fenómeno se localiza en otro de los cuatro niveles.

Regular consiste en dar a cada nivel las condiciones para retomar la función que cedió al nivel siguiente.

EL OBJETIVO DE LA SESIÓN

El objetivo de la sesión es el hallazgo y la corrección de lo que el rastreo marca.

El dolor puede ceder como consecuencia, y su persistencia no invalida el trabajo realizado sobre los nodos que sí respondieron.

25

Sobre qué opera la técnica

La técnica edita restricciones y reabre operadores; las metas y el horizonte quedan fuera.

El capítulo 24 situó el hallazgo dentro de la organización del dolor. Este lo sitúa dentro del sistema que se regula, con los cinco componentes que describió el capítulo 6, y responde a la pregunta de hasta dónde llega la intervención.

COMPONENTE POR COMPONENTE

COMPONENTE	QUÉ HACE LA TÉCNICA
O · Operadores	Los reabre. La célula conserva la función y ha perdido la señal que le indica cuándo ejecutarla; devuelto el voltaje de referencia, la función vuelve a estar disponible
C · Restricciones	Las edita. Es el trabajo que hace el dipolo cuando una zona quedó bloqueada por una adaptación que ya no corresponde
E · Evaluación	La toca en parte. Reescribir un punto de ajuste es intervenir sobre E, y el alcance de esa reescritura depende de cuánto la sostenga la persona por otras vías
S · Estados	Fuera de alcance. No se añaden configuraciones nuevas al sistema
H · Horizonte	Fuera de alcance. La anticipación con la que el sistema recibe información no se modifica con un campo magnético

Sobre el precio *w* la técnica tampoco interviene: no abarata lo que el tejido hace, abre la vía por la que puede hacerlo. Y el capítulo 6 estableció que sobre una vía cerrada, mover *w* no toca el problema.

Dicho en los términos del capítulo 6: la técnica trabaja sobre la columna de la información, y no sobre la de la maquinaria. No repone *S* ni añade operadores nuevos; edita *C*, devuelve la disponibilidad de los operadores que ya existen, y alcanza en parte a *E*.

«Nuestro modelo de regulación bioeléctrica no lo cura todo. Opera en O, opera en C. A veces un poco en E. Y nada más. Todas las demás letras dependen de la persona.»

NOTAS DE CLASE

QUÉ SIGNIFICA UN RESULTADO AUSENTE

Agotados los recursos del capítulo 15 –el dipolo local, la secuencia completa de nodos distantes y el rastreo del resto del cuerpo–, y descartado por el capítulo 24 que el fenómeno pertenezca a otro nivel del dolor, queda una tercera posibilidad: que el conflicto esté en un componente sobre el que la técnica no interviene.



«Si tú estás rastreando a alguien para arreglarle el intestino y no se arregla, no es ahí. No es el modelo. Pregúntate qué otra letra puede estar en conflicto.»

NOTAS DE CLASE

Un resultado ausente no invalida el hallazgo: reubica la pregunta. Y el caso particular del trinquete descrito en el capítulo 6 tiene su firma propia, que es la zona que responde en cada sesión y vuelve al mismo estado entre una y otra.

La coordinación, que el capítulo 6 designa con \Sigma, ocupa una posición intermedia. La técnica no la restablece de forma directa, pero sí trabaja sobre su sustrato cuando reabre las uniones comunicantes de una isla: lo que restablece es la pertenencia de ese grupo de células a la red, y no una función nueva.

26

La regla del imán

Un imán genera un gradiente que modifica el voltaje de la membrana. Nada más.

Un imán genera un gradiente que modifica el voltaje de la membrana. Nada más.

Esta regla cierra la cadena con la que abrió la Parte I, y de ella se desprenden las tres afirmaciones que delimitan la práctica.

EL RESULTADO DEPENDE DEL SITIO, NO DE LA POTENCIA

Los capítulos §7 y §9 lo establecieron por vías distintas: el efecto ocurre porque el campo deforma la geometría de la membrana, y el gradiente alcanza su máximo en la frontera entre polos opuestos. Ninguna de las dos cosas mejora con más intensidad. Un imán de mayor gaussaje colocado en el sitio equivocado no produce efecto; un imán moderado en el nodo correcto sí.

EL IMÁN NO DESINFLAMA NI SUSTITUYE A UN MEDICAMENTO

Modifica el voltaje de membrana, y a partir de ahí el tejido ejecuta lo que ya sabe hacer, que es lo que el capítulo 5 llamó recuperar la señal de referencia. La expresión correcta de lo que ocurre es que el tejido recupera esa señal, y no que el imán trate la enfermedad. De ahí también que el resultado se compruebe en los días siguientes y no en el momento.



LA LECTURA NO DEPENDE DEL OPERADOR

La respuesta la produce el cuerpo ante la perturbación del imán, por la vía descrita en el capítulo 12. Dos operadores distintos obtienen el mismo hallazgo sobre la misma persona, siempre que respeten la referencia izquierda y el procedimiento de medición del capítulo 13.

Esa es la propiedad que anunció el capítulo 1 y que solo puede afirmarse aquí, una vez descritos el indicador y el procedimiento que la sostienen. Con ella los casos se acumulan comparables entre sí, y la lectura deja de depender de la sensibilidad de quien explora.



PARTE II

Los ejes

Los siete ejes de trabajo: qué zona rastrea cada uno, en qué orden, y qué indica el nodo donde el hallazgo cierra.

BLOQUE VIII	Los ejes de entrada
BLOQUE IX	El eje transversal
BLOQUE X	El eje digestivo
BLOQUE XI	El eje metabólico
BLOQUE XII	Los ejes inflamatorio y redox



El razonamiento de los ejes

La Parte I dejó establecida una sola regla de búsqueda: se interroga una zona con el polo negativo, se confirma por acortamiento, se cierra con un dipolo local y, si no nivela, se sube por el orden fijo de nodos distantes. Esa regla no cambia. Lo que cambia de un eje a otro son las zonas que se interrogan, el orden en que se rastrean y, en el páncreas endocrino y en el hígado, la secuencia del nodo distante.

De ahí que la pregunta clínica no sea qué técnica aplicar, sino por dónde entrar. Un cuerpo tiene más zonas rastreables de las que caben en una sesión, y rastrearlas sin criterio produce hallazgos sueltos que no se pueden interpretar. El eje es ese criterio: un conjunto acotado de zonas que comparten un mecanismo, con un orden de rastreo propio y una lectura propia de lo que marca.

Los ejes no son siete técnicas distintas. Son siete recortes del mismo procedimiento sobre siete conjuntos de zonas, y la diferencia entre ellos está en qué componente del sistema interrogan. El nodo de lesión interroga una restricción local instalada por un traumatismo. El eje transversal interroga un ciclo de defensa que no terminó. El eje digestivo interroga la barrera y la motilidad de un tubo cuyo funcionamiento depende del voltaje en cada tramo. El eje metabólico interroga la coordinación entre cuatro órganos que dejaron de responder en el mismo orden.

Dos de los siete ocupan una posición aparte. La acidosis se corrige antes que nada, porque desplaza la medición basal y con ella todas las lecturas de la sesión: mientras la extremidad esté acortada sin imán colocado, ningún hallazgo posterior es interpretable. Y el eje transversal opera como sustrato, porque un cuerpo en tono defensivo sostenido produce hallazgos en cualquier zona que se interrogue, y esos hallazgos se resuelven en la sesión y vuelven a la siguiente.

De esa posición sale el orden general de trabajo. Primero la línea base. Después lo que empezó con un traumatismo, que es local y se resuelve donde ocurrió. Después el estado del cuerpo, que es lo que sostiene a los demás. Y solo entonces los ejes viscerales, cuyos hallazgos se leen mejor sobre un cuerpo que ya no está en alerta.

Ese orden admite excepciones, y las admite por una razón concreta: lo que la persona trae decide por dónde se empieza. Un cuadro que duele al movimiento entra por el nodo de lesión aunque el mapa muestre otras cosas. Una molestia digestiva de meses entra por su eje. El orden general dice qué se atiende cuando nada obliga a lo contrario; lo que la persona trae dice cuándo se altera.

Los capítulos que siguen describen cada eje con la misma estructura: qué mecanismo interroga, a quién se le aplica, qué zonas se rastrean y en qué orden, cómo se lee lo que marca, y dónde termina su alcance.

BLOQUE VIII

Los ejes de entrada

La acidosis, que se corrige antes de rastrear cualquier zona porque desplaza la medición basal, y el nodo de lesión, que atiende lo que empezó con un traumatismo y se resuelve donde ocurrió.

27

La acidosis

Se corrige antes de rastrear cualquier zona, y tiene dos formas.

El capítulo 13 estableció que la medición basal decide el curso de la sesión, y que un acortamiento sin imán colocado tiene dos causas posibles: una discrepancia real de longitud o el fenómeno bioeléctrico de acidosis. Este capítulo describe la segunda y su corrección.

POR QUÉ SE CORRIGE PRIMERO

Mientras la extremidad esté acortada sin imán, la referencia con la que se comparan todas las mediciones posteriores está desplazada. Un hallazgo obtenido sobre esa base no distingue entre la respuesta a la zona interrogada y el acortamiento previo.

La corrección de la acidosis establece la línea base sobre la que el resto de la sesión se puede leer.

EL RIÑÓN COMO ÓRGANO RESPONSABLE

El riñón es el único órgano que regula los iones de todo el organismo, y un desplazamiento de 1 mmol produce desequilibrio bioeléctrico en tejidos distantes. Es la misma razón por la que encabeza el orden fijo del capítulo 15.

LA SECUENCIA COMPLETA

Es la única colocación del método que se inicia con el polo positivo. En las demás el rastreo abre con el negativo, y el positivo entra después a cerrar el dipolo.

1 · La persona se coloca en la camilla.



CONTINÚA

- 2 · Se miden los pies.
- 3 · Si uno se encuentra desfasado –generalmente el derecho–, se plantea la hipótesis de una acidosis.
- 4 · Se coloca el POSITIVO sobre la zona renal de la extremidad que acorta.
- 5 · Se mide.
 - Nivela → la hipótesis se confirma: hay acidosis.
 - Sigue igual → el cuadro no es acidosis. Se pasa al rastreo por zonas.
- 6 · Se coloca el NEGATIVO en el mismo lugar.
- 7 · Se deja de 15 a 20 minutos.
 - Se retiran los dos polos, el negativo primero. Se mide.
 - Isométricas → la corrección quedó hecha.
 - Sigue acortado → paso 8.
- 8 · Se recoloca el POSITIVO sobre la zona renal derecha, y el complementario pasa al PARIETAL CONTRALATERAL, en lugar de ir sobre el mismo riñón.

El retiro de esta colocación sigue un criterio propio. El capítulo 18 establece que se retira solo el positivo y se mide, porque lo que se comprueba es si esa zona se resolvió. Aquí se retiran los dos, porque lo que se comprueba es distinto: si la línea base se sostiene sin ningún imán puesto.

La colocación del positivo es la prueba diagnóstica y no el tratamiento. El acortamiento basal admite dos explicaciones —una discrepancia real de longitud o una acidosis— y esta colocación las separa: si nivela, era acidosis.

ACIDOSIS LATENTE

El paso 8 corresponde al acortamiento que persiste después de la corrección, y que indica un estado sostenido y no un episodio del día.

La colocación cambia de local a distante: el positivo sobre la zona renal derecha y el negativo sobre el área parietal contralateral, siempre en polaridad contraria. El dipolo cruza el cuerpo.

POLO	REFERENCIA SOBRE LA PIEL
Positivo, zona renal derecha	Ángulo costovertebral derecho, entre el borde inferior de la duodécima costilla y el borde lateral de los músculos erectores
Negativo, área parietal izquierda	Sobre el hueso parietal, por encima y por detrás del pabellón auricular, entre la sutura coronal y la lambdoidea

Se denomina nodo renal-parietal. Es el nodo por el que empieza la sesión cuando el acortamiento basal reincide; con extremidades isométricas se pasa directamente al rastreo por zonas, según el capítulo 13.

A esta colocación se le aplica el criterio general del capítulo 18: cumplidos los 20 minutos se retira el positivo y se mide; si nivela, se retira el negativo, y si no, se recoloca y se prolonga.

LOS TRES EFECTOS DE LA ACIDOSIS LATENTE

TERRITORIO	CÓMO SE MANIFIESTA
Cerebro	Dificultad de concentración, olvidos, cefalea
Vía respiratoria	Fragilidad, secreción de moco por las mañanas, tendencia a enfermar
Orina	Orina ácida, con riesgo de cistitis sin microorganismo que la explique

La cefalea que responde a este nodo es la que aparece sin contexto que la explique. La cefalea tensional y la que sigue a una ingesta de alcohol tienen otra causa y no corresponden a este eje.



CUÁNDO SE REPITE

En cefalea persistente que no ha respondido a otros tratamientos, el rastreo se repite cada tres días de forma continua. El tamaño del imán corresponde al del riñón de esa persona, según la regla del capítulo 8.

Establecida la línea base, la sesión puede leer lo que la persona trae. El capítulo siguiente atiende el caso más frecuente.

28

El nodo de lesión

Atiende la isla bioeléctrica que dejó un traumatismo, y se cierra en uno de cinco lugares.

El capítulo 14 describió cómo se forma una isla bioeléctrica y cómo se delimita. Este describe cómo se resuelve.

A QUIÉN SE LE APLICA

A toda zona que sufrió un golpe, una herida, una extracción dental, una intervención quirúrgica o un traumatismo, y también a la que estuvo expuesta a un fármaco o a un agente químico.

El antecedente orienta la búsqueda, y la respuesta la confirma. Una zona con antecedente que no acorta no tiene isla; una zona que acorta sin antecedente recordado la tiene igual.

LOS CINCO CIERRES POSIBLES

El dipolo se cierra en uno de cinco lugares:

- 01 Zona con zona, en gradiente empinado.
- 02 Zona con riñón.
- 03 Zona con suprarrenal.
- 04 Zona con hígado.
- 05 Zona con bulbo raquídeo.

La búsqueda sigue el orden fijo del capítulo 15 –los seis nodos distantes y, tras ellos, el rastreo del resto del cuerpo– y se detiene en el primero que restablece la isometría. Un cierre hallado en ese rastreo final se anota con su localización, porque queda fuera de los cinco catalogados.

Agotada la secuencia completa sin que ninguna posición nivele, el operador registra el hallazgo, deja el nodo local sin dipolo y pasa al eje siguiente.

La lectura de lo que cada cierre indica es la del capítulo 16, que vale igual para todos los ejes: el cierre local corresponde a una isla acotada al lugar, y cada nodo por encima compromete un órgano regulador más.

LA REGLA OPERATIVA

Se coloca el imán y se deja que el cuerpo diga sí o no.

El operador llega con hipótesis sobre dónde estará el hallazgo, y esas hipótesis desplazan la lectura si se le pregunta al cuerpo por ellas. El procedimiento consiste en colocar el polo negativo sobre la zona y medir, sin anticipar el resultado en voz alta.

No se trabaja por diagnóstico. Ante un dolor extendido, lo que se pide es el mapa del capítulo 22 y se rastrean las zonas que la persona marcó.

CUÁNDO SE AGREGA LA REJILLA

Cuando hay lesión del aparato locomotor –rotura muscular, contractura, tirón, desgarre, esguince o fractura consolidada– con liberación de calcio y potasio y gradiente inflamatorio, se monta la rejilla del capítulo 17 sobre el nodo ya confirmado.

En la variante combinada se mantiene el dipolo distante y se monta la rejilla sobre el polo negativo, de modo que se trabajen a la vez el componente local y el sistémico.

EL CONTORNO DE LA ISLA

El contorno de la isla se marca sobre la piel y se traslada al expediente, según el capítulo 14. En la sesión siguiente se vuelve a interrogar esa misma zona: las islas antiguas reaparecen en función de la edad, el estado nutricional y la carga acumulada.

Este eje resuelve lo que empezó en un lugar. El capítulo siguiente establece cuándo el dolor que la persona trae admite ese abordaje y cuándo pertenece a otro.



29

Los tipos de dolor

El dolor nociceptivo es el que esta técnica trabaja; el neuropático y el nociplástico piden otro procedimiento.

El capítulo 24 situó el hallazgo en cuatro niveles de organización del dolor y estableció que la técnica opera en el primero. Este traduce esa distinción a la clínica, porque el tipo de dolor que la persona trae decide si el eje del nodo de lesión le corresponde.

LOS TRES TIPOS

TIPO	QUÉ LO ORIGINA	CÓMO SE PRESENTA	EJEMPLOS
Nociceptivo	Daño real en el tejido, con activación de nociceptores	Patrón mecánico: cambia con el movimiento y la posición, y evoluciona con el tejido	Artrosis, esguince, contractura, fractura consolidada
Neuropático	Lesión del sistema somatosensorial	Distribución segmentaria, calidad quemante o eléctrica	Neuropatía diabética, herpes zóster
Nociplástico	Sin daño tisular ni lesión del nervio demostrables	Difuso, sin patrón mecánico, con más de 3 meses de evolución	Fibromialgia, migraña crónica

POR QUÉ LA DISTINCIÓN DECIDE LA CONDUCTA

El dolor nociceptivo corresponde al primer nivel, que es donde la colocación de un imán modifica el voltaje del tejido. Ahí el eje del nodo de lesión se aplica de forma directa.

El neuropático y el nociplástico se sostienen en los niveles segmentario, de modulación y de red. Rastrear la zona dolorosa en esos casos produce con frecuencia el hallazgo del capítulo 24: la zona duele y la medición no cambia, porque el mecanismo opera en otro nivel.

El umbral temporal del nociplástico es de 3 meses. A partir de ahí, el propio dolor se acompaña de lo que la persona piensa sobre él, y ese componente pertenece al cuarto nivel.

QUÉ SE HACE EN LOS OTROS DOS

Se trabaja el eje transversal del bloque siguiente, que interroga el estado del cuerpo y no la zona. Un dolor sostenido en los niveles altos se acompaña casi siempre de tono defensivo elevado, y ese sí responde.

BLOQUE IX

El eje transversal

El programa de defensa y su ciclo, el tono que queda elevado cuando el ciclo no termina, y los dos conjuntos de nodos bilaterales con los que se trabaja el estado del cuerpo.

30

El programa de defensa

Tiene tres tiempos, y falla de dos maneras.

Los ejes anteriores interrogan un lugar. Este interroga un estado, y para eso hace falta describir primero qué programa lo produce.

LOS TRES TIEMPOS

TIEMPO	QUÉ OCURRE
Inicio	El tejido reconoce el daño y libera la señal que pone en marcha el programa
Ejecución	Las citocinas movilizan células al sitio, con los signos clínicos habituales
Resolución	Lipoxinas, resolvinas y protectinas retiran la señal y devuelven el tejido a su estado basal

La resolución es un programa activo con moléculas propias, y no la extinción espontánea del anterior. Un tejido no vuelve al basal porque se agote la inflamación: vuelve porque un segundo programa la termina.

De ahí que un proceso pueda quedarse en la fase de ejecución de forma indefinida sin que nada nuevo lo alimente.

LAS DOS FORMAS DE FALLAR

FALLA	QUÉ OCURRE	QUÉ PIDE
Rigidez	El sistema queda atascado en un modo y no transita al siguiente	Retirar lo que mantiene el modo activo
Déficit	Falta el sustrato con el que se fabrican las moléculas de la resolución	Reponer el sustrato



La primera corresponde a una restricción en los términos del capítulo 6, y es sobre la que la técnica interviene. La segunda es maquinaria, y se repone por otra vía.

EL CICLO DEFENSIVO TIENE CUATRO ETAPAS

Lo que en el tejido son tres tiempos, en el organismo completo son cuatro etapas:

Señales · activación · ejecución · descarga.

En la persona el ciclo se interrumpe casi siempre en la descarga. La movilización ocurre, la respuesta se ejecuta, y la fase que devuelve al organismo a su estado basal no llega a completarse, porque la situación exige seguir, o porque el contexto no admite la descarga.

Esa interrupción es lo que este eje atiende.

31

El tono de defensa

Se regula en tres escalas, y tiene memoria.

LAS TRES ESCALAS

ESCALA	CÓMO SE OBSERVA
Muscular	Tensión sostenida, guardia, contractura. Visible en rostro, mandíbula y cinturas
Autonómica	El estado del sistema nervioso autónomo, que el capítulo 35 describe con la ventana de tolerancia
Inflamatoria	La resolución del capítulo 30 no llega, y el programa permanece en ejecución

Las tres se mueven juntas. Una persona con el tono elevado se explora distinto, se mide peor y resuelve más lento, y esa diferencia aparece en cualquier zona que se interroge.

ES UN PUNTO DE AJUSTE, Y POR ESO SE PUEDE REESCRIBIR

El tono no es una cualidad de la persona: es una referencia graduable, en el sentido del capítulo 6. Está en la columna de la información, no en la de la maquinaria, y de ahí que un campo magnético pueda modificarlo.

El término del método es tono. No se emplea el vocabulario de las escuelas que hablan de mecanismos de defensa, porque describe otra cosa.

EL TONO TIENE MEMORIA

Un tono elevado se instala por aprendizaje asociativo, sin que medie una decisión. Se ha demostrado en animales que una señal neutra, presentada junto con un estímulo que modula la respuesta inmunológica, termina produciendo esa modulación por sí sola.

Y si el tono se aprende, se le puede enseñar. Esa es la premisa sobre la que trabaja este eje.

32

El ciclo defensivo completo

Seis fases, tres simpáticas y tres parasimpáticas, y quedarse atrapado es no llegar a la última.

El capítulo 30 describió el ciclo en cuatro etapas funcionales. Este lo describe en las seis fases que el rastreo distingue.

FASE		ESTADO
1	Activación y orientación	Simpático
2	Huida en espera	Simpático
3	Defensa activa	Simpático
4	Inmovilidad tónica	Parasimpático
5	Colapso, con disociación o despersonalización	Parasimpático
6	Quietud que repara	Parasimpático

El ciclo termina en la fase 6. Quedarse atrapado es no llegar a ella.

EL PARASIMPÁTICO NO EQUIVALE A CALMA

Tres de las seis fases son parasimpáticas y solo la última corresponde a un estado de reparación. La inmovilidad tónica y el colapso también lo son, y en la exploración se presentan como quietud.

De ahí que una persona en fase 4 o 5 pueda parecer tranquila y estar en el extremo opuesto de la ventana. El capítulo 35 da los signos con los que se distinguen.

**EL MISMO HECHO, DICHO EN TRES LENGUAJES****LENGUAJE CÓMO SE ENUNCIA**

Etológico	Un ciclo defensivo que no llegó a su última fase
Predictivo	Una predicción de amenaza que no ha recibido evidencia en contra
Bioeléctrico	Islas de tejido que se desconectaron del colectivo y no se han reincorporado

Son tres descripciones del mismo fenómeno, y la tercera es sobre la que este eje interviene.

33

Los nodos del eje del estrés

Se localizan donde pasa un paquete neurovascular, y el nombre designa siempre la zona anatómica.

LAS OCHO ZONAS, NODO POR NODO

Cada nodo se localiza por un reparo óseo o muscular palpable. Las referencias son de anatomía de superficie, y se comprueban con la mano antes de colocar.

Cabeza

NODO	REFERENCIA SOBRE LA PIEL
Vértice	Punto más alto del cráneo, donde la línea sagital media cruza la línea que une los dos pabellones auriculares
Occipital	Sobre la protuberancia occipital externa, en la línea media posterior
Glabela, con su complementario en la depresión suboccipital	La glabela, en la línea media, entre los arcos superciliares y por encima de la raíz de la nariz. Su complementario, también en la línea media, en la depresión entre la protuberancia occipital externa y el arco posterior del atlas
Fosa suboccipital, detrás del mastoides	En el surco entre la apófisis mastoides y la apófisis transversa del atlas, por debajo del borde del occipital
Fosa retromandibular	Entre el borde posterior de la rama de la mandíbula y la apófisis mastoides, inmediatamente por debajo del pabellón auricular
Área temporal, sobre el masetero	Fosa temporal y vientre del masetero, a uno y otro lado del arco cigomático

Cuello

NODO	REFERENCIA SOBRE LA PIEL
Paravertebral cervical	A un través de dedo de la línea de apófisis espinosas cervicales, sobre la masa muscular
Fosa yugular	Escotadura de la línea media por encima del mango del esternón, entre las dos inserciones esternales del esternocleidomastoideo
Esternocleidomastoideo	Sobre el vientre del músculo, en su tercio medio, entre la mastoides y la clavícula
Fosa supraclavicular	Por encima del tercio medio de la clavícula, por detrás del borde posterior del esternocleidomastoideo

Tórax

NODO	REFERENCIA SOBRE LA PIEL
Área xifoesternal	En la unión del cuerpo del esternón con el apéndice xifoides, en el ángulo que forman los rebordes costales
Deltopectoral	Surco entre el deltoides y el pectoral mayor, por debajo del tercio lateral de la clavícula
Precordio	Quinto espacio intercostal izquierdo, sobre la línea medioclavicular

Espalda

NODO	REFERENCIA SOBRE LA PIEL
Cada vértebra, una a una	Sobre la apófisis espinosa, de la segunda cervical al cóccix
Área paravertebral	A dos traveses de dedo de la línea de apófisis espinosas, sobre la masa de los músculos erectores
Borde superior del trapecio	A media distancia entre el acromion y la base del cuello
Borde vertebral de la escápula	Sobre el borde medial, de la espina de la escápula al ángulo inferior



Abdomen

NODO	REFERENCIA SOBRE LA PIEL
Epigastrio	Entre el apéndice xifoides y la línea horizontal que pasa por el punto más bajo de los rebordes costales
Mesogastrio	Franja media del abdomen, alrededor del ombligo
Hipogastrio	Entre el ombligo y la sínfisis del pubis
Ombligo	Sobre el anillo umbilical
Fosas ilíacas	Derecha e izquierda, en el triángulo entre la espina ilíaca anterosuperior, el ombligo y la sínfisis del pubis
Región subcostal	Por debajo del reborde costal, de la línea medioclavicular a la axilar media

Pelvis

NODO	REFERENCIA SOBRE LA PIEL
Espina ilíaca posterosuperior	Bajo el hoyuelo lumbar, a la altura de la segunda vértebra sacra
Espina ilíaca anterosuperior	Extremo anterior de la cresta ilíaca
Región inguinal	Sobre el ligamento inguinal, entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo del pubis
Fosa del trocánter	Depresión inmediatamente por detrás y por encima del trocánter mayor
Perineo	Entre el borde inferior de la sínfisis del pubis y la punta del cóccix

Miembro superior

NODO	REFERENCIA SOBRE LA PIEL
Región supraolecraniana	Sobre el tendón del tríceps, por encima del olécranon
Fosa antecubital	Pliegue anterior del codo, entre el bíceps y el epicóndilo
Tercio distal del antebrazo	Cara anterior, por encima de los pliegues de la muñeca
Muñeca	Cara anterior, sobre los pliegues de flexión
Dorso de la mano	Entre el primero y el segundo metacarpios

Miembro inferior

NODO	REFERENCIA SOBRE LA PIEL
Tensor de la fascia lata	Cara lateral de la cadera, por debajo y por delante de la espina ilíaca anterosuperior
Ojos de la rodilla, que son cuatro	Dos por encima, a uno y otro lado del borde superior de la rótula; dos por debajo, a uno y otro lado del tendón rotuliano
Hueco poplíteo	Cara posterior de la rodilla, en el rombo entre los isquiotibiales y los gemelos
Tendón de Aquiles	Tercio medio, por encima de la inserción en el calcáneo
Canal retromaleolar	En el surco entre el maléolo y el tendón de Aquiles
Empeine	Dorso del pie, entre el primero y el segundo metatarsianos
Planta del pie	Centro de la planta, sobre la fascia plantar

QUÉ TIENEN EN COMÚN

Todos se localizan donde pasa un paquete neurovascular: un nervio, una arteria y una vena juntos, con retroalimentación autónoma. En la cabeza corresponden además a depresiones óseas que definen la vascularidad de la región.

El nombre designa la zona anatómica. Ninguno lleva nombre de órgano.



SOBRE EL NÚMERO

Las designaciones anatómicas de la lista suman 40. El número 41 resulta de contar la depresión suboccipital como entrada propia, en lugar de como el complementario posterior de la glabella. Ese conteo está pendiente de fijarse, y no altera el procedimiento: se rastrean todas las zonas y se aplican solo los nodos que marcan.

REGLAS DEL RASTREO

- Se rastrea todo el conjunto y se aplican solo los nodos que marcan.
- Más de 3 nodos en una misma zona es un dato clínico que se anota.
- No es necesario colocarlos todos en una sesión. Los que alcancen a colocarse se registran, y la serie continúa.

EL UMBRAL QUE CLASIFICA EL CUADRO

El conteo se hace sobre este conjunto. Más de 6 nodos marcados clasifican el cuadro como sistémico; 6 o menos corresponde al conflicto del día.

Sistémico quiere decir que el estado va a repercutir a largo plazo en el metabolismo, en el dolor y en la digestión. El seis clasifica el cuadro y no detiene el rastreo: con 2 nodos se anota como hallazgo local y se sigue; con más de 6 se anota como sistémico y se sigue igual.

Ese umbral es también la condición que manda colocar el conjunto bilateral del capítulo siguiente.

34

Los 10 nodos bilaterales

Interrogan el estado del cuerpo, y no el lugar.

Junto al conjunto anterior, el eje dispone de un segundo conjunto, más corto y siempre bilateral.

	NODO	REFERENCIA SOBRE LA PIEL
1	Vértice	Punto más alto del cráneo, a uno y otro lado de la línea sagital media
2	Base del cráneo	Bajo el borde del occipital, a uno y otro lado de la protuberancia occipital externa
3	Supraclavicular	Por encima del tercio medio de la clavícula, por detrás del esternocleidomastoideo
4	Escápulas	Borde medial, entre la espina de la escápula y el ángulo inferior
5	Tricipital	Cara posterior del brazo, sobre el tercio medio del tríceps
6	Zona renal	Ángulo costovertebral, entre el borde inferior de la duodécima costilla y el borde lateral de los músculos erectores
7	Suprarrotuliano	Por encima del borde superior de la rótula, sobre el tendón del cuádriceps
8	Tendón de Aquiles	Tercio medio, por encima de la inserción en el calcáneo
9	Empeine	Dorso del pie, entre el primero y el segundo metatarsianos
10	Cervical con sacro	La apófisis espinosa de la séptima cervical y la línea media del sacro. Es el único del conjunto que forma dipolo de arriba abajo

POR QUÉ SON BILATERALES

El plano bioeléctrico precede y define la simetría corporal. En animales, modificar de forma temprana un canal de sodio o de potasio produce órganos que no rotan o que se sitúan del lado contrario, sin que el material genético cambie.

De ahí la distinción operativa que gobierna este conjunto:

Un nodo unilateral interroga el lugar. Un dipolo bilateral interroga el estado del cuerpo.

Cuando los hallazgos se vuelven simétricos, el nivel dejó de ser local. La bilateralidad puede darse de izquierda a derecha, de frente hacia atrás –la glabella con su complementario suboccipital, al mismo nivel– y en algunos casos de arriba abajo.



POLARIDAD

El polo negativo se coloca del lado derecho y el positivo del izquierdo. Es una de las dos colocaciones del método con lateralidad fija –la otra es el nodo renal-parietal del capítulo 27–: en el nodo local, el negativo va donde el rastreo lo confirme.

CUÁNDO SE COLOCAN

Se colocan cuando el conteo del capítulo 33 clasifica el cuadro como sistémico, y pueden colocarse solos cuando lo que se quiere trabajar es el tono defensivo.

Algunos se traslapan con los del capítulo 33: se completan únicamente los que no salieron en el rastreo previo.

LA EXCEPCIÓN A LA REGLA DE CONFIRMACIÓN

El capítulo 15 estableció que una zona que no acorta no se trabaja. Este conjunto es la excepción, y se declara como tal: se coloca como serie completa, sin exigir que la medición confirme cada nodo por separado.

La razón es la del capítulo 11: un dipolo bilateral interroga el estado del cuerpo y no un lugar, y ese estado no se localiza en un nodo. El conjunto opera junto o no opera.

Con estos nodos colocados, los puntos dolorosos de la zona reducen su intensidad, y vuelven a doler si se retira uno de ellos.

35

La ventana de tolerancia

Da el vocabulario con el que se describe el estado, sin nombrar emociones.

LOS DOS EXTREMOS

ESTADO	CÓMO SE PRESENTA
Hiperactivación	Boca seca, tensión muscular, frecuencia cardíaca elevada, digestión inhibida, urgencia urinaria, molestia a la luz
Hipoactivación	Mareo con oscurecimiento de la visión, audición reducida, entumecimiento, sensación de pesadez, distancia respecto del propio cuerpo

El operador registra el estado con estos términos y no con nombres de emoción. La razón es la del capítulo 37: nombrar un afecto cambia lo que el operador hace a continuación.

LOS SIGNOS QUE SE PREGUNTAN

Boca seca o húmeda · tensión muscular · frecuencia del pulso · digestión · mareo · visión borrosa · color y temperatura de las manos · saciedad temprana o náusea · urgencia para orinar, incluida la nocturna · molestia a la luz.

Se registran al abrir la sesión, dentro del mapa del capítulo 22, y se vuelven a preguntar al cerrar.

EL CUESTIONARIO DE HIPOACTIVACIÓN

13 preguntas sobre desmayos, oscurecimiento de la visión, dificultad para ver alrededor, audición reducida, entumecimiento, inmovilidad, insensibilidad al dolor, pesadez, rigidez, náusea, sensación de estar fuera del cuerpo, imposibilidad de hablar y debilidad repentina.

Cada una se puntúa de 0 a 3, donde 0 es nunca y 3 es cinco veces o más por semana. En las personas sin hallazgos el promedio por pregunta se sitúa entre 0.8 y 2 puntos, y por encima de esa cifra hay signos de hipoactivación, que corresponden a carga de estrés sostenida.

36

La conducción de la sesión

Cuatro pasos con la palabra, mientras los nodos están colocados.

Los nodos colocados abren una ventana en la que el sistema admite información nueva. Lo que el operador dice durante esa ventana forma parte del procedimiento.

LOS CUATRO PASOS

- 1 · RECONOCER
Lo que la persona siente, se reconoce. No se corrige ni se interpreta.
- 2 · RESPIRAR
Tres ciclos en cuatro-cuatro-seis: inhalar 4 segundos, sostener 4, exhalar 6.
Se dice en voz alta: puedo respirar y seguir sintiendo lo que estoy sintiendo.
- 3 · AMPLIAR LA CONCIENCIA
Hacia un lugar o una persona que dé seguridad.
- 4 · PREGUNTAR A LA SENSACIÓN
De qué protege. Y al final: te puedo soltar.

El segundo paso es el que hace el trabajo. Sostener la sensación y respirar a la vez contradice la predicción de que eso no se puede, y esa contradicción es la información nueva que el sistema recibe.



QUÉ SE LE DICE A LA PERSONA

«Estos puntos le van a entregar una información que no va a coincidir con la amenaza que estás prediciendo. Si la mantienes lo suficiente, el mismo sistema se actualiza. No se va a apagar la alarma: solamente se le va a mostrar que ya no hay incendio.»

NOTAS DE CLASE

LA PALABRA FORMA PARTE DEL PROGRAMA

Lo que el operador dice entra al sistema por la misma vía que cualquier otra señal. Frases sobre el estado del cuerpo de la persona –que tiene la columna desgastada, que el daño es importante– elevan el tono que la sesión trabaja.

Lo que dice el operador son instrucciones, y se eligen con el mismo cuidado que la colocación.

QUÉ SE OBSERVA DURANTE LA PERMANENCIA

Movimiento ocular, que indica que el sistema entró en el estado. Somnolencia y necesidad de descanso. Temblores espontáneos o sacudidas musculares, que corresponden a descarga. Cambios en la voz.

La descarga es un signo que confirma que algo ocurre. Se acompaña con presencia, se registra y se deja pasar sin interpretarla. La sesión está completa aunque no aparezca, y las descargas pueden presentarse en los días siguientes, con más frecuencia al tercero.

Si aparece descarga, se acompaña con la contradicción del paso 2 y no se interrumpe. Una descarga que se favorece de forma amable es reprocesamiento; una que se fuerza es retraumatización.

37

Qué separa esta técnica de una terapia emocional

Cinco razones, y ninguna es de encuadre.

Este eje trabaja estados que la persona vive como emociones, y de ahí que la distinción tenga que quedar establecida.

Una. Trataría la emoción como enfermedad, cuando es un estado posible del sistema. El método interroga el microambiente del tejido, según el capítulo 1, y una emoción no es un hallazgo de esa clase.

Dos. Cambiaría lo que hace el operador, que pasaría de rastrear a dirigir. La regla del capítulo 28 –colocar y dejar que el cuerpo responda– deja de aplicarse en cuanto el operador persigue un contenido.

Tres. Queda fuera del alcance de esta formación, que no forma psicoterapeutas. El capítulo 1 fijó el límite profesional y aquí opera igual.

Cuatro. Sube la ganancia del síntoma. Nombrar el afecto hace que la persona lo persiga, y eso amplifica lo que se pretendía regular. De ahí el vocabulario del capítulo 35: hiperactivado en lugar de ansioso.

Cinco. Confunde la lectura, porque impide distinguir qué cambio es atribuible a la colocación.

«Desde mi punto de vista, no existe el biomagnetismo emocional. O si se hace, en realidad es otra cosa.»

NOTAS DE CLASE

LO QUE SÍ SE MIDE

Lo que la sesión persigue no es que la persona se sienta bien. Es que el ciclo defensivo llegue a su fase 6 y que la amplitud de la ventana de tolerancia aumente con las sesiones.

Una sensación agradable durante la sesión no confirma nada, del mismo modo que el capítulo 18 estableció que la mejoría inmediata no confirma el resultado. Lo que se compara es el mapa de sensaciones entre una sesión y la siguiente.



BLOQUE X

El eje digestivo

Por qué la función de cada tramo del tubo depende de su voltaje, las 11 unidades que se rastrean, el orden en que se atienden y qué obliga a derivar antes de colocar.

38

El epitelio y el voltaje

Todas las funciones del epitelio dependen del voltaje de membrana.

El capítulo 3 estableció que el voltaje determina qué secreta una glándula y qué deja pasar una unión estrecha. El tubo digestivo es donde esa dependencia se comprueba tramo por tramo.

QUÉ DEPENDE DEL VOLTAJE

Digerir, secretar ácido clorhídrico, fabricar enzimas y funcionar como barrera dependen del voltaje de las células de cada tramo. Cuando ese voltaje se altera, cambian las capacidades del tejido sin que su estructura se haya modificado.

La secreción de ácido lo muestra con claridad: la bomba que lanza hidrógeno y cloro hacia la luz del estómago cambia el voltaje de la célula al hacerlo. Secretar y polarizarse son el mismo acto.

EL RECAMBIO DA EL ARGUMENTO CLÍNICO

El epitelio se renueva cada 3 a 5 días, y el estómago completo en 21 días. El estómago que una persona tiene hoy tiene 21 días, y no un año, salvo que haya perdido la capacidad de reparar.

Y esa capacidad se pierde al perder la bioelectricidad. De ahí que un cuadro digestivo de años no se explique por el daño acumulado sino por una reparación que dejó de completarse.

LA PERMEABILIDAD ES UNA RESTRICCIÓN

La permeabilidad intestinal corresponde a la letra C del capítulo 6, y su causa principal es la caída de la resistencia eléctrica del epitelio.

Esa resistencia se mide aplicando corriente a través de una monocapa de células: a mayor resistencia, más íntegras están las uniones estrechas. La unión estrecha decide por carga y por tamaño, y deja pasar lo que pesa menos de 50 000 daltones – agua, aminoácidos, ácidos grasos y azúcares. Lo que pesa más, no.

Cuando pasa lo que no debería, el tejido linfoide asociado a la mucosa responde y eleva el punto de ajuste de la zona.

El imán trabaja sobre las claudinas, las proteínas que forman la unión estrecha. Una despolarización del tejido las desplaza, y la colocación revierte ese desplazamiento.

EL ACOPLAMIENTO CAE ANTES QUE EL TEJIDO

La conexina 43, que forma las uniones comunicantes de este epitelio, disminuye antes de que aparezca daño anatómico. Para perder la conexina tiene que haber ocurrido primero un cambio eléctrico.

Una célula que cierra sus uniones comunicantes conserva su estructura y pierde la información de qué posición ocupa en el gradiente. Es la isla bioeléctrica del capítulo 14, aplicada al tubo: la célula deja de saber si es colon o si es estómago.

39

Las 11 unidades funcionales

El tubo se rastrea por unidades, porque la posición decide la función.

Una célula gástrica colocada en el colon cambia lo que hace. La función no está en la célula: está en la posición que ocupa dentro del gradiente, y por eso el tubo se divide en unidades que se interrogan por separado.

Cada unidad tiene regulación propia y puede alojar islas bioeléctricas propias.

LAS 11 UNIDADES Y DÓNDE SE RASTREA CADA UNA

	UNIDAD	REFERENCIA SOBRE LA PIEL
1	Esófago	Línea media anterior, del hueco supraesternal al apéndice xifoides
2	Estómago	Hipocondrio izquierdo y epigastrio, bajo el reborde costal izquierdo
3	Duodeno	Epigastrio, a la derecha de la línea media, del apéndice xifoides hasta un través de mano por encima del ombligo
4	Yeyuno	Mesogastrio izquierdo, a un través de mano a la izquierda del ombligo
5	Íleon	Cuadrante inferior derecho, a un través de puño del ombligo hacia la fosa ilíaca derecha



	UNIDAD	REFERENCIA SOBRE LA PIEL
6	Válvula ileocecal	Punto de McBurney: unión del tercio externo con los dos tercios internos de la línea que va del ombligo a la espina iliaca anterosuperior derecha
7	Colon ascendente, transverso y descendente	El marco cólico: flanco derecho, franja subcostal transversa y flanco izquierdo
8	Recto, en dos zonas	Una anterior, en el hipogastrio bajo, por encima de la sínfisis del pubis; otra posterior, sobre el cóccix
9	Glándulas salivales	Sobre las parótidas, por delante y debajo del pabellón auricular, y en el piso de la boca, bajo el borde de la mandíbula
10	Páncreas	Epigastrio, de la línea media al hipocondrio izquierdo, a un través de mano por encima del ombligo
11	Hígado con su vesícula	Parrilla costal derecha, de la línea medioclavicular a la axilar media y hasta la cara posterior. La vesícula, en el punto cóstico: cruce del reborde costal derecho con la línea medioclavicular

El recto se rastrea en dos zonas, y no en una. El hígado y la vesícula forman una sola unidad funcional.

CÓMO SE RASTREAN

Se rastrea de arriba hacia abajo, siguiendo el sentido del tránsito. El rastreo identifica la zona reactiva y la respuesta es el dipolo, con la regla del capítulo 15.

El imán ha de ser pequeño. Las islas de este eje también lo son, y un imán que abarque más superficie que la isla no la localiza, según el capítulo 8.

CUÁNTAS UNIDADES HACEN CRÓNICO UN CUADRO

Una o dos unidades marcadas corresponden a lo normal, y más de 3 unidades funcionales indican un cuadro crónico. Tres exactas se anotan como cuadro en transición y se comparan con la sesión siguiente.

40

Las células intersticiales de Cajal

Son el marcapasos del tubo, y generan la onda antes de la contracción.

LA ONDA PRECEDE AL MOVIMIENTO

Las células intersticiales de Cajal generan una onda eléctrica, y la contracción viene después. El músculo no decide moverse: recibe una onda y se contrae.

El canal que la produce se denomina ANO. Al bloquearse, se altera el flujo de calcio, se altera el voltaje de membrana y se pierde el peristaltismo.

LAS FRECUENCIAS DE CADA TRAMO

TRAMO	ONDAS POR MINUTO
Estómago	3
Duodeno	12
Íleon	6 a 9
Colon	Sin gradiente propio

El estreñimiento corresponde a una pérdida de ondas eléctricas, y esa es la razón por la que no cede con el aporte de fibra: la fibra da volumen a un tubo que ha perdido la señal que lo mueve.

LOS TRES ESFÍNTERES

Los esfínteres permanecen cerrados en reposo. Abrirlos exige una orden, y esa orden es inhibitoria: liberación de óxido nítrico, liberación de péptidos, y una onda eléctrica de las células de Cajal.

Un píloro que no recibe esa orden produce plenitud, estancamiento y vaciamiento lento.

La hernia hiatal superpone dos esfínteres distintos, y son dos estructuras separadas, cada una con su propio punto de ajuste:

ESFÍNTER	QUÉ ES
Anatómico	La unión entre el esófago y el estómago
Muscular	Los pilares del diafragma que la rodean

El esfínter anal mantiene su tono por el mismo canal ANO.



41

El orden interno del eje

Motilidad, barrera y resolución, en ese orden.

Los hallazgos de este eje se atienden en una secuencia fija, y el motivo es que cada uno condiciona al siguiente.

1 · La motilidad. Primero se atiende lo que va aguas abajo, porque depende de una onda eléctrica que se puede corregir. Las técnicas que facilitan el drenaje lo hacen porque facilitan la motilidad.

2 · La barrera. Después, los lugares que se abren de más o que se cierran de más, según el capítulo 38.

3 · La resolución. Al final, los programas que siguen activos y no han terminado, en el sentido del capítulo 30.

LAS SEIS PIEZAS SOBRE LAS QUE LA BIOELECTRICIDAD INFLUYE

Epitelio · músculo · esfínteres · hígado · inmunidad · sistema entérico.

Y el límite se dice sin rodeo: los imanes no quitan la gastritis. No son un antiácido.

Lo que hacen es actuar sobre el sistema entérico para que regule su punto de ajuste, y sobre el epitelio para que recupere su capacidad de reparar.

«Nosotros con los imanes lo que vamos a hacer es ayudarle como un operador al intestino a influir sobre su bioelectricidad. Nada más. No es ponerle imán para la gastritis, ni imán para la colitis.»

NOTAS DE CLASE

42

La entrada al eje

Tres preguntas sustituyen al diagnóstico.

El capítulo 1 estableció que el mapa no se deduce del nombre de una enfermedad. En este eje esa regla toma la forma de tres preguntas que abren la consulta.

¿QUÉ PASA QUE NO DEBERÍA DE PASAR?

¿Qué no avanza cuando le toca? ¿Qué respuesta ha empezado y no termina?

Las tres apuntan a los tres momentos del capítulo 41: lo que ocurre y no corresponde señala la barrera; lo que no avanza señala la motilidad; lo que empezó y no termina señala la resolución.

Se pide a la persona que describa lo que le pasa, y no que aporte un diagnóstico. La formulación que abre es «cuénteme qué pasa ahora que no pasaba antes».

43

La reprogramación vagal bioeléctrica

El hepatocito despolarizado deja de informar al tronco encefálico.

El hígado es la unidad 11 del rastreo, y tiene además un mecanismo propio que justifica una colocación específica.

EL MECANISMO

El hígado envía información al tronco encefálico por el aferente vagal hepático. Cuando el hepatocito se carga de lípido se despolariza, y esa despolarización aumenta la liberación hepática de GABA. El GABA deprime la descarga del aferente, y el tronco deja de recibir la señal.

El hígado sigue procesando, y deja de informar. Es la distinción del capítulo 6 entre maquinaria e información, en un órgano concreto: S y O están intactos, y lo que falla es lo que el sistema sabe.

LA COLOCACIÓN

Al cambiar la polaridad de la zona hepática se restablece la descarga del aferente, y con ella el criterio con el que el tronco regula. La técnica se denomina reprogramación vagal bioeléctrica, y ese nombre sustituye al antiguo de hepatitis tóxica.

El hígado aparece en tres posiciones distintas del método, y se anota en cuál apareció, porque significan cosas diferentes:

POSICIÓN	QUÉ ES
Unidad 11 del eje digestivo	El hígado con su vesícula, como unidad funcional
Nodo distante del orden fijo	El hígado como punto de ajuste de otra unidad
Eje metabólico	Una zona del rastreo hepático, según el Bloque XI



44

Qué se pregunta y qué se anota

Las preguntas de este eje miden tiempos, y los tiempos orientan el tramo.

LA HISTORIA DEL EJE

Del inicio. Desde cuándo ocurre. Qué pasó justo antes. Si empezó de un día para otro o de forma gradual.

De los tiempos. Cuántos minutos pasan entre comer y la aparición de la molestia. Cuántas horas hasta que cede. Las dos cifras hacen falta para la revisión de la sesión siguiente.

De la tolerancia. Cuántos alimentos le caen mal hoy, cuántos hace un año, y si son los mismos.

De la reparación. Cuánto tarda en cerrar una herida.

Del ritmo. Horarios de las comidas, hora de la cena y hora del primer alimento del día. Las horas entre una y otra son el tiempo que el estómago pasa en ayuno.

De los fármacos. Qué toma, y cuántos ciclos de antibiótico ha llevado en el último año.

LOS TIEMPOS ORIENTAN EL TRAMO

LO QUE LA PERSONA CUENTA	QUÉ TRAMO APUNTA
Se llena antes de terminar el plato	Estómago, con problema de ritmo
Ardor de 1 a 3 horas después de comer	Duodeno
La grasa no se digiere	Falta de bilis
Heces de color pálido	Bloqueo de la vía biliar
Se atora la comida en el pecho, regurgita o eructa	Esófago y unión esofagogástrica

Estos tiempos orientan el tramo por el que se abre el rastreo. El capítulo siguiente da las banderas que obligan a derivar antes de aplicar cualquier colocación.

45

Qué obliga a derivar en este eje

Siete cuadros van al médico antes que a la camilla, y cinco situaciones quedan fuera del protocolo.

A las nueve banderas rojas del capítulo 20 se agregan siete propias de este eje.
El operador deriva al médico sin rastrear:

- 01 Sangrado.
- 02 Palidez y falta de aire después de una diarrea, que orientan a anemia.
- 03 Dolor que despierta por la noche, o dolor agudo.
- 04 Pérdida de 10 kilos en 15 días.
- 05 Fiebre.
- 06 Cambio del ritmo intestinal de más de 6 semanas.
- 07 Vómito y diarrea persistentes en persona mayor.

No se interpreta el cuadro ni se formulan hipótesis.

LO QUE QUEDA FUERA DEL ALCANCE DE ESTE PROTOCOLO

SITUACIÓN	POR QUÉ
Atrofia importante de la mucosa	Corresponde a daño estructural, con probable déficit de zinc o de vitaminas
Resección quirúrgica previa	El tramo ya no está
Órgano ausente	Sin órgano no hay zona que interrogar: es un operador menos, en los términos del capítulo 6
Cirrosis establecida	Es la degeneración orgánica del capítulo 4, que queda fuera del método
Infección activa con fiebre	Corresponde a las urgencias del capítulo 21

Después de una infección intestinal la técnica se aplica cuando el cuadro está resuelto. Un proceso infeccioso eleva el punto de ajuste de la zona, y ese es precisamente el hallazgo que el rastreo va a encontrar cuando la persona se recupere.



BLOQUE XI

El eje metabólico

Los cinco lugares donde se pierde la coordinación entre cuatro órganos, cuáles admiten edición, y los cuatro rastreos con los que se atiende cada uno.

46

Los cinco lugares de falla

Tres admiten la colocación, y dos quedan fuera.

LA COORDINACIÓN, Y NO EL VALOR

Cuatro órganos sostienen el trabajo metabólico: el músculo, el páncreas, el hígado y el tejido adiposo. Mientras responden coordinados en el tiempo, el sistema tolera cargas altas sin que el cuadro progrese. Lo que decide el curso es si esos cuatro siguen respondiendo en el mismo orden, y no la cifra de un análisis.

Un conflicto metabólico es una falla de coordinación entre órganos, entre tejidos y entre escalas. Es el tercer modo de falla del capítulo 6, el que ahí se designa con la letra griega mayúscula: las partes conservan lo que saben hacer y pierden el orden entre ellas.

DÓNDE FALLA, Y QUÉ SE PUEDE EDITAR

LUGAR	QUÉ FALLÓ	COMPONENTE	¿SE PUEDE EDITAR?
1 · Músculo	Perdió la conmutación entre quemar glucosa y quemar grasa	O	Sí, con movimiento y ventanas de ayuno
2 · Anticipación	El horizonte se desplazó: el sistema deja de recibir la señal antes de que la carga llegue	H	No con la colocación. Depende de que exista la vía por la que llega la información
3 · Coordinación celular	Las células del páncreas dejaron de acoplarse entre sí	Σ	Sí, y aquí entra la colocación
4 · Cerebro	El punto de ajuste de la glucosa subió	E	Sí, restableciendo el reporte vagal del hígado
5 · Tejido	La glucosa se unió a proteínas de vida larga	C	No. Es un trinquete, en los términos del capítulo 6

El quinto es la restricción que no se retira. Corresponde a la definición del trinquete: la unión ocurre sin enzima, avanza en un solo sentido, y el organismo no dispone de la reacción de vuelta.

QUÉ RASTREO ATIENDE CADA LUGAR

Los cuatro rastreos de este bloque no son cuatro variantes de lo mismo: cada uno atiende un lugar distinto de la tabla.

RASTREO	LUGAR QUE ATIENDE
Los nueve nodos de inflexibilidad, capítulo 47	El lugar 1: la conmutación perdida del músculo
El páncreas endocrino, capítulo 48	El lugar 3: el acoplamiento entre las células que secretan
El hígado, capítulo 49	El lugar 4: el reporte vagal que fija el punto de ajuste, según el capítulo 43
El tejido adiposo, capítulo 50	El depósito donde se acumula la carga que el músculo dejó de usar

El lugar 2 y el lugar 5 quedan fuera de la colocación. El horizonte no se edita con un campo magnético, por la razón que da el capítulo 6. Y el trinquete del lugar 5 no se retira: lo único que cabe ahí es frenar lo que entra.



LA CARGA ACOMPAÑA SIEMPRE AL RASTREO

Un tejido en medio hostil vuelve a desacoplarse después de la sesión.

Restablecer el acoplamiento mientras la carga sigue alta es pedirle a la célula que renuncie a su protección, y por eso este eje se acompaña siempre de la reducción de esa carga: menos aceite, menos azúcar y ventanas de ayuno son parte del plan, y corresponden a la persona.

47

Los nueve nodos de inflexibilidad metabólica

Cuentan cuántos responden, y no cuál responde primero.

QUÉ PATRÓN BUSCAN

Este rastreo no busca el músculo peor. Busca un patrón bioeléctrico repartido en nueve nodos, que aparece cuando el sistema se replegó hacia el ahorro.

El repliegue corresponde a una impronta de escasez: en algún momento hubo que sobrevivir con menos, y el organismo sigue operando desde esa marca aunque la escasez ya no esté. Fijado del lado del ahorro, el músculo no conmuta aunque haya glucosa disponible.

LOS NUEVE NODOS

Ordenados de arriba abajo, y del tronco hacia las extremidades:

	NODO	REFERENCIA SOBRE LA PIEL
1	Mediastino superior	Sobre el mango del esternón, entre el hueco supraesternal y el ángulo esternal
2	Mediastino inferior	En la unión del cuerpo del esternón con el apéndice xifoides
3	Pectoral	Tercio medio del pectoral mayor, entre la clavícula y el pliegue axilar anterior
4	Línea axilar media	Entre el sexto y el séptimo espacios intercostales, sobre la vertical que baja del vértice de la axila
5	Suprarrenales	Ángulo costovertebral, a la altura de la duodécima costilla, por encima de la zona renal

	NODO	REFERENCIA SOBRE LA PIEL
6	Fosa antecubital	Pliegue anterior del codo, entre el bíceps y el epicóndilo
7	Muñeca	Cara anterior, sobre los pliegues de flexión
8	Cuádriceps	Tercio medio del recto femoral, en la cara anterior del muslo
9	Tendón de Aquiles	Tercio medio, por encima de la inserción en el calcáneo

CÓMO SE RASTREAN

Se interrogan los nueve, sin detenerse en el primero que marca. Lo que importa es cuántos responden, porque el hallazgo es un patrón y no un nodo.

NODOS MARCADOS	QUÉ INDICA
Los 9	Patrón heredado. Corresponde a una memoria de bajo umbral
Menos de 6	Patrón transitorio: sedentarismo reciente, exceso de carga, ausencia de ventanas de ayuno

La banda entre 6 y 8 nodos marcados queda sin clasificar, y se anota el conteo hasta que el registro de casos permita fijarla.

Heredado no significa irreversible. El músculo conserva la maquinaria: lo que ha perdido es la capacidad de conmutar, que es un problema de la columna de la información y no de la de la maquinaria, en los términos del capítulo 6.

A QUIÉN SE LE APLICA

SITUACIÓN	INDICACIÓN
Persona sin enfermedad declarada	Al sedentario. El estudio del que sale este patrón se hizo en jóvenes sedentarios con glucosa normal
Persona con enfermedad metabólica	Siempre. Sin recuperar la conmutación, ningún tratamiento la devuelve



Y una precisión que la consulta pide: la actividad de la vida diaria no equivale a movimiento. Lo que este patrón necesita es esfuerzo que ponga al músculo en demanda, y no desplazamiento cotidiano bajo carga de estrés.

CÓMO SE COMPRUEBA

El cociente respiratorio mide lo mismo que este rastreo interroga, y da una cifra independiente con la que comprobar el resultado.

VALOR	QUÉ INDICA
1	El organismo está usando glucosa
0.7 a 0.9 tras horas sin comer	La vía de la beta-oxidación también opera
1 sostenido tras el ayuno	Hay inflexibilidad metabólica

Si tras la colocación el valor desciende de 1 a 0.7, la conmutación se restableció. Es la comprobación más directa de que la técnica produjo el efecto que enuncia, y el diseño con el que este eje se puede poner a prueba.

48

El páncreas endocrino

Cuatro zonas, con un orden de nodo distante propio.

POR QUÉ SE RASTREA

Las células que producen insulina trabajan acopladas entre sí por la conexina 36, y esa conexión hace que secreten en pulsos. En un medio hostil la célula retira sus conexinas y se aísla, con lo que conserva su contenido y pierde el ritmo del conjunto.

Es la isla bioeléctrica del capítulo 14, en el páncreas: la célula sigue entera y deja de pertenecer a la red. Ese es el hallazgo que el rastreo busca.

LAS CUATRO ZONAS

	ZONA	SOBRE LA PIEL
1	Proceso unciforme	Epigastrio derecho, profundo, bajo el reborde costal
2	Cabeza	Epigastrio derecho, hacia la línea media
3	Cuerpo	Epigastrio, cruzando la línea media
4	Cola	Hipocondrio izquierdo, hacia el bazo

Se rastrean de derecha a izquierda, de la cabeza a la cola. La mayor densidad de células productoras de insulina está entre el cuerpo y la cola.

Las zonas 3 y 4 son profundas —el páncreas es retroperitoneal— y piden imán de bocina o placa de gradiente, según el capítulo 10. El imán es pequeño, del tamaño de la zona.

EL ORDEN DISTANTE DE ESTE RASTREO

Este rastreo no sube por el orden fijo del capítulo 15. Tiene una secuencia propia:

- 1 · Riñón
- 2 · Hígado
- 3 · Estómago
- 4 · Íleon
- 5 · Precordial
- 6 · Bulbo raquídeo

La suprarrenal no forma parte de esta secuencia. Se detiene en el primero que restablece la isometría, con el mismo criterio de parada de todos los rastreos.

CÓMO SE LEE LO QUE MARCA

DÓNDE CIERRA	QUÉ INDICA
Local	Aislamiento transitorio del islote: exceso de carga, inflamación pasajera
Riñón	Inflamación que elevó el punto de ajuste del órgano; con frecuencia, un proceso infeccioso
Estómago o íleon	Alteración del microambiente intestinal, con el punto de ajuste elevado

Los cierres en hígado, precordial y bulbo no tienen lectura establecida, y se anotan hasta que el registro de casos permita darla.

49

El hígado

Cinco zonas, porque la grasa no llega igual a todas.

DOS GRASAS DISTINTAS LLEGAN POR VÍAS DISTINTAS



	GRASA METABÓLICA	GRASA TÓXICA
De dónde viene	Entró, se procesó, el músculo la rechazó y vuelve al hígado	Entró ya alterada desde el alimento
Por dónde llega	Por vías venosas aberrantes, distintas de la vena porta	Por la vena porta
Qué rastreo pide	El rastreo por zonas de este capítulo	El rastreo del hígado como unidad, según el capítulo 39

Todo lo que se absorbe entre el esófago y el sigmoides pasa por la vena porta. Una grasa que llega al hígado sin haber pasado por ahí entró por otra ruta, y esas rutas alimentan territorios concretos que se despolarizan primero.

LAS CINCO ZONAS

	ZONA	SOBRE LA PIEL
1	Hiliar	Epigastrio derecho, bajo el reborde costal, hacia la profundidad
2	Lecho vesicular	Punto cístico: cruce del reborde costal derecho con la línea medioclavicular
3	Ligamento falciforme	Línea media, del apéndice xifoides hacia el ombligo
4	Lecho izquierdo	Epigastrio, a la izquierda de la línea media
5	Masa derecha	Hipocondrio derecho, la extensión del órgano

El orden va de lo específico a lo general. Las cuatro primeras son territorios acotados de flujo aberrante; la quinta es extensa, y va al final para no tapar a las otras.

Las zonas 1 y 4 son profundas y piden gradiente empujado.

EL ORDEN DISTANTE DE ESTE RASTREO

Cuando el hígado es lo que se interroga, sale de la secuencia:

- 1 · Riñón
- 2 · Suprarrenal
- 3 · Bulbo raquídeo

Agotada esa secuencia, el eje metabólico continúa con el tejido donde se acumula la carga que el músculo dejó de usar. Es el objeto del capítulo siguiente.

50

El tejido adiposo

Cinco zonas accesibles, y el abdomen concentra la mayor parte de los hallazgos.

POR QUÉ SE RASTREA

El adipocito se despolariza al acumular lípido. Y los depósitos de grasa no se comportan igual entre sí: cada uno tiene su propio drenaje, su propia fisiología y su propio riesgo.

LAS CINCO ZONAS ACCESIBLES

Se rastrean de lo protector a lo disfuncional, para disponer de un término de comparación antes de llegar a la zona de mayor carga:

	ZONA	SOBRE LA PIEL
1	Glúteo-femoral	Cara lateral de cadera y muslo
2	Cervical-supraclavicular	Base del cuello, sobre la clavícula
3	Perirrenal y retroperitoneal	Flanco, bajo las últimas costillas, en profundidad
4	Intramuscular	Sobre cualquier vientre muscular grande, con prioridad en el muslo
5	Abdominal	Periumbilical, y en profundidad hacia el mesenterio

El abdomen concentra la mayor parte de los hallazgos. Las zonas 3 y 4 piden gradiente empinado, por profundidad o por volumen de tejido interpuesto.

La grasa epicárdica y la de la médula ósea quedan pendientes de decisión. El mapa escrito las declara inaccesibles desde la piel; en clase se propuso rastrearlas por las tibias, el sacro y las alas pélvicas. Hasta que se resuelva, se anota si existe compromiso de esos depósitos por diagnóstico previo, sin rastrearlos.

CUÁNDO SE INDICA

CRITERIO	UMBRAL
Índice de masa corporal	Por encima de 26
Prioritario	Por encima de 30



La medición de impedancia bioeléctrica localiza en qué depósito está la grasa, y orienta por dónde empezar el rastreo.

51

La grasa que no se rastrea

La que conserva un punto de ajuste queda fuera.

No toda la grasa que aparece en el mapa corresponde a este eje. Parte de ella cumple una función que sigue vigente, y en ese caso el punto de ajuste que la sostiene es correcto.

DEPÓSITO	QUÉ FUNCIÓN CUMPLE
Lipoma	Protección de una zona, con la misma lógica que un callo
Grasa del pecho	Protección
Grasa de la espalda	Protección frente a una carga sostenida

La colocación no trabaja esos depósitos mientras la meta que los produjo siga activa. Es la lectura del capítulo 6 sobre las restricciones: retirarlas cuando todavía corresponden desorganiza el sistema en lugar de regularlo.

Este eje trae además un límite que se dice a la persona:

NO TODO SE TRATA CON IMANES

Cuando la persona pide que se le retire un depósito que cumple una función, lo que corresponde es decírselo, y no rastrearlo.

El caso cambia cuando ese mismo depósito presenta inflamación. Entonces la zona inflamada sí entra, por el eje del bloque siguiente.

BLOQUE XII

Los ejes inflamatorio y redox

La regla que vale para cualquier órgano inflamado, los cuatro sitios arteriales, las ventanas de descanso, y la oxidación que avanza con los años.

52

El nodo de órgano o tejido inflamado

Cualquier órgano inflamado se rastrea con la misma regla.

Los ejes anteriores tienen zonas fijas. Este no: se aplica a cualquier órgano o tejido inflamado que quede accesible desde la piel, y por eso es el procedimiento al que se recurre cuando el órgano a interrogar todavía no tiene mapa propio en el método.

LA REGLA

Como regla general, todo órgano o tejido inflamado tiene al menos un conflicto bioeléctrico local, y se rastrea.

- 1 · LA ZONA
El órgano inflamado, donde queda más cerca de la piel.
- 2 · INTERROGAR
Imán pequeño, polo negativo, cara negativa a la piel.
Con imán de bocina, el centro negativo contra la piel.
Medir.
Acorta → nodo confirmado.
Sin cambio → mover dentro del órgano y volver a medir.
Sin cambio en todo el órgano → ese órgano no sostiene el cuadro por esta vía.
- 3 · NODO LOCAL ADYACENTE
El segundo imán al lado, dentro del mismo órgano.
Isométricas → nodo local. Se deja.
Sin isometría → paso 4.
- 4 · SIMETRÍA CONTRALATERAL, SOLO SI EL ÓRGANO ES BILATERAL
El nodo equivalente del lado opuesto.
Isométricas → nodo local por simetría. Se deja.
Sin isometría, u órgano impar → paso 5.
- 5 · NODO DISTANTE, POR EL ORDEN FIJO DEL CAPÍTULO 15

El nodo local adyacente se busca siempre primero, sea el órgano par o impar. La simetría contralateral es el segundo recurso, y solo existe cuando hay un equivalente del otro lado.

Si el órgano es profundo, cambia el imán y no la lógica: se emplea el de bocina o la placa de gradiente. En la bocina, la polaridad que actúa es la del centro, según el capítulo 10.

QUÉ LO DISTINGUE DEL NODO DE LESIÓN

Los dos rastrean una zona y buscan su complementario. La diferencia está en el antecedente: el nodo de lesión atiende lo que empezó con un golpe y tiene historia; este atiende un órgano inflamado sin traumatismo que lo explique.

UN EJEMPLO DE LA CONDUCTA COMPLETA

Una tiroides con nódulo se rastrea sobre la glándula. Si el nodo adyacente no nivela, se prueba el lóbulo contrario antes de subir al orden fijo, porque el órgano es bilateral.

Y el mismo caso ilustra el límite del eje. El punto de ajuste que sostiene la inflamación puede seguir vigente, y entonces la colocación se repite sesión tras sesión sin que el hallazgo se retire. Es la situación que el capítulo siguiente atiende.

53

Las ventanas de descanso

Retiran del tejido la carga que mantiene el ciclo activo.

Cuando la meta que activa al tejido sigue vigente, el ciclo de defensa del capítulo 30 no puede terminar: cada vez que se retira la señal, la situación vuelve a producirla.

La ventana de descanso es un periodo en el que el tejido deja de recibir esa carga. Cumple en el eje inflamatorio la misma función que la ventana de ayuno cumple en el metabólico: interrumpe la entrada para que el programa de resolución alcance a ejecutarse.

CUÁNDO SE INDICAN

En los cuadros donde la exposición es continua y no se puede editar todavía. La conducta consiste en organizar el retiro de la carga durante un periodo definido, y no en pedir que la situación cambie.

La ventana no resuelve la meta: le da al tejido el intervalo que necesita para reparar mientras la meta sigue ahí.

54

La placa arterial

Cuatro sitios, y cualquier hallazgo se deriva.

POR QUÉ ENTRA EN ESTE EJE

La placa comparte el mecanismo del eje: el macrófago que la habita es el mismo agente, con la misma pregunta de si resuelve o no resuelve. Y la pérdida de acoplamiento del endotelio habilita que el proceso avance, con el mismo patrón que el capítulo 14 describe para la isla.

La placa se instala donde el flujo deja de ser laminar: en las bifurcaciones y en las curvas, donde el roce de la sangre sobre el endotelio cae.

LOS CUATRO SITIOS

SITIO	REFERENCIA SOBRE LA PIEL
Bifurcación carotídea	Borde anterior del esternocleidomastoideo, a la altura del borde superior del cartílago tiroides
Cayado de la aorta	Detrás del mango del esternón, entre el hueco supraesternal y el ángulo esternal
Aorta abdominal	Línea media, del epigastrio al ombligo, algo a la izquierda
Arterias femorales	Triángulo femoral, en el punto medio del ligamento inguinal, entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis

La aorta abdominal es profunda y pide gradiente empinado. En el cayado, la placa se reconoce en una radiografía como una zona de mayor densidad.

QUÉ SE HACE CON EL HALLAZGO

Cualquier hallazgo en este rastreo se deriva al médico con estudio de imagen. El dato que mejor caracteriza el riesgo de una placa —el espesor de la cápsula que la cubre— no es accesible desde la piel, y un rastreo de superficie no distingue una placa estable de una que no lo es.

El registro de estos hallazgos sirve para acumular casos, y no para decidir una conducta sobre la placa.



55

El eje redox

Trabaja la oxidación que avanza con los años, junto con el inflamatorio.

EN QUÉ SE DISTINGUE DEL INFLAMATORIO

Los dos ejes intervienen sobre el mismo tipo de proceso y difieren en el mecanismo que lo produce:

EJE	QUÉ LO PRODUCE
Inflamatorio	Un ciclo de defensa que se activó ante un evento y no resolvió
Redox	Una oxidación lenta, por falta de antioxidantes o por exposición prolongada

Por eso se trabajan juntos. El rastreo es el mismo del capítulo 52: se coloca sobre la zona y se busca su nodo local.

SU LUGAR EN EL ORDEN DE TRABAJO

Este eje no compite por entrar primero en una sesión. Corresponde al fondo sobre el que los demás ocurren, y se atiende de forma continua.

El rastreo busca la zona que perdió su integración, y no la mancha ni el signo visible: un tejido oxidado que no se ha reparado no vuelve por sí solo a su linaje celular.

EL ENVEJECIMIENTO, EN TÉRMINOS ELÉCTRICOS

El envejecimiento, en términos eléctricos, corresponde a dejar de tener una meta.

Es la letra E del capítulo 6 llevada al tiempo largo. Una célula que deja de perseguir una meta deja de ejercer su función, y el tejido que la contiene envejece antes que el resto.

De ahí sale la indicación que este eje deja para la persona: ampliar los horizontes en lugar de reducirlos. Cada etapa de la vida abre metas nuevas, y sostener una sola durante décadas es lo que el eje encuentra como pérdida de integración.



PARTE III

Conducción y seguimiento

Con qué eje se empieza, qué se hace cuando el rastreo no da hallazgos, cómo se conduce la serie y hasta dónde llega el método.

BLOQUE XIII

La sesión y la serie





El razonamiento de la conducción

La Parte I dio una regla de búsqueda y la Parte II dio siete conjuntos de zonas donde aplicarla. Falta lo que ocurre cuando una persona llega y hay que decidir en qué orden se atiende, cuántas sesiones lleva y en qué momento el método deja de ser la respuesta.

Esa decisión no la toma un protocolo de cribado. La toma lo que la persona trae, leído sobre el orden general del bloque de apertura de la Parte II. El orden dice qué se atiende cuando nada obliga a lo contrario; la consulta dice cuándo se altera.

Y una sesión no agota el mapa. Al resolverse los nodos de mayor respuesta aparecen otros que antes no marcaban, de modo que el trabajo es una serie y no un acto. Lo que la serie persigue no es la desaparición del síntoma sino que el rastreo deje de dar hallazgos, y ese es también el criterio con el que termina.

De ahí que el manual termine en el límite. Un método que dice hasta dónde llega puede afirmar con precisión qué hace, y con esa precisión se trabaja junto al médico en lugar de en su lugar.

BLOQUE XIII

La sesión y la serie

Con qué eje se empieza en cada caso, qué hacer cuando el rastreo no da hallazgos, cómo se organiza la serie de sesiones y dónde termina el alcance del método.

56

Con qué eje se empieza

La primera pregunta descarta el nodo de lesión; después decide lo que la persona trae.

EL ORDEN DE LA SESIÓN

- 1 · MEDICIÓN BASAL
Isométricas → se pasa al rastreo por zonas.
Acortamiento → eje de acidosis, capítulo 27.
- 2 · LA PRIMERA PREGUNTA
¿Duele algo al moverse?
Sí → nodo de lesión, capítulo 28.
No → queda descartado ese eje.
- 3 · EL EJE QUE LA CONSULTA INDICA
Se elige por la sintomatología que la persona trae.
- 4 · EL EJE TRANSVERSAL
Se agrega cuando el estado del cuerpo lo pide, según el conteo del capítulo 33.

La medición basal va primero siempre, porque de ella depende que lo demás se pueda leer.

CÓMO SE DECIDE EN LA CONSULTA

Cuatro situaciones muestran el reparto.

Un niño de 8 años con amigdalitis de repetición, fiebres y respiración oral. Entra por el eje inflamatorio: la zona inflamada se rastrea con la regla del capítulo 52. Y se agrega el eje transversal cuando la conversación con la madre muestra un contexto que mantiene el tono elevado. La placa arterial no corresponde a esta edad.



Una mujer de 26 años que no logra embarazarse, con ciclos alterados, obesidad y colesterol elevado. Entra por el eje metabólico, porque el colesterol elevado corresponde al desbordamiento de varios procesos pequeños y no a una meta del sistema. Se agrega el nodo de órgano sobre el ovario, y el eje transversal si el estado lo pide.

Un hombre de 60 años con crecimiento prostático, retención urinaria repetida, repercusión renal e hipertensión, con colesterol y triglicéridos altos. Entra por el nodo de órgano sobre la próstata, se agrega el eje metabólico, y a esta edad sí corresponde rastrear los sitios arteriales del capítulo 54. El eje transversal se agrega solo si hay un estado que lo justifique.

Una mujer con molestia gástrica persistente y endoscopia sin hallazgos. Entra por el eje digestivo, con las tres preguntas del capítulo 42. Se agrega el nodo de órgano sobre la zona que refiere, y el eje transversal cuando el relato muestra una carga sostenida.

UN CASO QUE NO ENTRA

Una persona con sangrado rectal activo. No se rastrea y no se coloca nada. El operador deriva al médico, según los capítulos 21 y 45.

LA REGLA DE DOSIS

Un eje dominante por sesión. Los demás se anotan y se atienden en las sesiones siguientes.

57

Cuando el rastreo no da hallazgos

Se cambia de eje, y la ausencia también se anota.

Un rastreo que no da hallazgos no significa que no haya nada. Significa que la escala interrogada no es la del proceso.

QUÉ SE HACE

Se cambia de eje y se rastrea de nuevo. Si el eje transversal ya no da nodos porque las sesiones previas los resolvieron, el trabajo pasa al eje digestivo; si ese tampoco da, al siguiente, en el orden del bloque de apertura.

Un rastreo sin hallazgos también es información, y se anota como tal. En la sesión siguiente ese registro distingue entre una zona que nunca respondió y una que dejó de responder.

CUÁNDO EL HALLAZGO PERTENECE A OTRO NIVEL

Agotados los ejes, quedan las dos lecturas de la Parte I:

LECTURA	DÓNDE ESTÁ
El fenómeno se organiza en un nivel del dolor distinto del tisular	Capítulo 24
El conflicto está en un componente que la técnica no edita	Capítulo 25

En los dos casos el resultado ausente no invalida el hallazgo: reubica la pregunta.

58

La serie de sesiones

El método atiende una condición, y se repite a lo largo del tiempo.

LA REGULACIÓN SE HACE EN EL TIEMPO

El método no atiende una enfermedad. Atiende una condición, y por eso se repite: cada semana, cada quincena o con el intervalo que el caso pida, con la misma lógica del servicio periódico de un equipo que trabaja de forma continua.

De ahí que se aplique también a personas sin enfermedad declarada. El sedentario del capítulo 47 y la persona con carga sostenida del capítulo 31 tienen hallazgos rastreables sin tener un cuadro que los explique.

CADA SESIÓN DESCUBRE LO QUE LA ANTERIOR TAPABA

Una sesión no agota el mapa. Al resolverse los nodos de mayor respuesta, en la siguiente aparecen otros que antes no marcaban. La serie continúa mientras el rastreo siga dando hallazgos, y ese es también el criterio con el que termina.

Sin el registro del capítulo 22, el operador no distingue un nodo nuevo de uno que ya trabajó.

QUÉ SE COMPARA ENTRE SESIONES

DATO	DE DÓNDE SALE
Cuánto le duró	La pregunta de apertura, capítulo 22
El mapa de sensaciones	Las cifras de la sesión anterior, capítulo 22
Los nodos que siguen marcando	El registro del rastreo previo
La amplitud de la ventana	Los signos del capítulo 35

Lo que se compara es la permanencia del cambio entre una sesión y la siguiente, y no cómo se siente la persona ese día.



QUÉ ESPERAR EN LOS DÍAS SIGUIENTES

La reparación ocurre en las horas y los días posteriores, ya sin el imán colocado. Pueden aparecer descargas, con más frecuencia al tercer día, y se acompañan con el criterio del capítulo 36.

59

Hasta dónde llega el método

Lo que no marca en ningún eje se deriva.

EL LÍMITE, DICHO POR PARTES

DÓNDE TERMINA	QUÉ QUEDA FUERA
Por clase de agente	La clase A: lo que solo cambia cambiando la estructura, según el capítulo 5
Por componente	S y H, y el precio de cada operador. La técnica edita C, reabre O y alcanza en parte a E, según el capítulo 25
Por nivel del dolor	Los niveles 2, 3 y 4, según el capítulo 24
Por estado del tejido	La degeneración orgánica establecida, según el capítulo 4
Por cuadro clínico	Las nueve banderas rojas del capítulo 20 y las urgencias del capítulo 21
Por punto de ajuste vigente	Lo que sigue cumpliendo una función, según el capítulo 51

LA CONDUCTA ANTE EL LÍMITE

No todo se trata con imanes. Cuando el rastreo no marca en ningún eje, el cuadro queda fuera del alcance del método y se deriva.

Decirlo forma parte del procedimiento, y es lo que distingue al operador que conoce su alcance del que promete lo que no puede dar.

LA POSICIÓN PROFESIONAL

La evaluación se realiza sin necesidad de formación médica, según el capítulo 1. El método no sustituye ningún tratamiento médico, y el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad corresponden al médico.

Con la persona, la formulación que corresponde no promete un resultado: describe lo que la sesión hace.



Se trabaja para que el tejido recupere su señal de referencia, y el cuerpo se encarga del resto.

COLOFÓN

Manual de Regulación Bioeléctrica del programa El Cuerpo Eléctrico. Se compuso a partir de las cuatro clases impartidas del programa, y recoge únicamente el procedimiento de Regulación Bioeléctrica.

Redacción y dirección clínica: Dr. Miguel Ojeda Rios.
Instituto Centrobioenergetica. Edición 2026.



INSTITUTO
CENTROBIOENERGETICA